

ICUの人間的ケア（Hotel ICU）

口渇・睡眠・環境・家族ケア・記憶とせん妄の人間化、当院Hotel ICUの運用まで

聖路加国際病院 集中治療科

対象：研修医・専攻医・看護師

最終更新 2026-10-09

ケア・組織 | 人間的ケア 早見表

ICUの人間的ケアは、口渇・睡眠・環境・面会・記憶・身体抑制・退室後という7つの場面に分かれます。数値目標が少ないテーマなので、この表は「基準値」よりも「いつ・誰に・何を確認するか」の入口として使ってください。詳しい根拠は本文の各章にあります。

表1 | 数値目標と実施のタイミング — [迷ったらここに戻る](#)

領域	基準・設定	実施のタイミング	出典
口渇 NRS（強度・苦痛の2問）	軽度 0-4／中等度 5-6／ 重度 7-10	5点以上で介入対象 。毎日全例に、視診より先に聞く	[AJCC2022]
口渇バンドル（氷水スワブ・メントールリップ）	1時間ごと	日中は10～17時の毎正時が目安。効果が1時間で戻るための頻度で、回数を増やすためではない	[Doi ICNS2021]
TOURS（挿管患者のwell-being）	4項目・ α 0.83	1日2回以上 。実施不能なら「実施不能」と記録する	[TOURS CritCare2026]
J-RCSQ（睡眠）	総得点のみ	毎朝。対象は 非挿管・非鎮静・せん妄なし のみ。単項目は使わない	[Murata NursOpen2019]
Quiet Time	夜間 21:00～翌6:00	頭側1mのアラーム音量・モニター輝度を 先に下げる （引き算が先、耳栓・アイマスクは後）	[当院 Hotel ICU]
面会	緩和を既定に	感染対策だけを理由にしない。 17ステートメント中で唯一の強い推奨	[SCCM2024]
身体抑制の記録	6項目	理由／部位数／総抑制時間／決定者／医師指示の有無／家族への通知。抑制のたびに記録	[ANZICS ICM2020]
ABCDEFバンドル	6要素すべて	実施割合が上がるほど転帰が改善する用量反応。「やるか／やらないか」で止めない	[Pun CCM2019]
退室後訪問	1回目5分／2回目10分	1回目＝退室翌日・全例 。2回目＝退室3～5日目・ハイリスクのみ	[当院 Hotel ICU]
家族の心理評価	HADS・IES-6	3か月・6か月に固定し、 入室時ベースラインも取る 。ベースラインなしでは「PICS-Fによる悪化」と言えない	[PICS-F AcuteMedSurg2024]
死別後支援	段階的に	お悔やみの手紙 単独 は避ける。面談→訪問→死後面談の3ステップで	[PICS-F AcuteMedSurg2024]

この症例で考える

72歳男性。市中肺炎による敗血症性ショックでICU入室、5日間の人工呼吸ののち本日午前抜管。経鼻カニューラ3L、意識清明、RASS 0、CAM-ICU陰性。嚥下評価は明朝の予定で、いまは飲水禁止です。

深夜2時、かすれた声で「水…」と繰り返しています。バイタルは安定、口腔内は夕方の口腔ケアで湿って見えます。受け持ち看護師が「氷片、少しだけあげていいですか」と聞いてきました。日中に付き添っていた奥さんは帰り際、「昨夜は一睡もできていないみたいで、私も何もしてあげられなくて」と言い残しています。**あなたはどうか答え、何を確認しますか。**

§1 総論 — 非人間化とICUの人間化、この領域をなぜ学ぶか

この章で決めるのは全体の見取り図です。ICUでいちばん多い苦痛は何か、なぜ良い意図が現場に届かないのか、そして人間的ケアの不足を個人の心がけの問題にしてはいけない理由を先に押さえてから、各論に入ります。

1-1. 人間化とは何か、なぜ必要か

非人間化 (dehumanization) とは、人を「人格」ではなく「物」として扱うことです [Wilson CritCare2019]。臓器不全の是正に追われるあまり、臨床医は患者が何を体験しているかを十分に考えないことがあります。死の淵にあり、話せず、裸にされ、見知らぬ者が説明なく身体に触れ、多数のチューブを入れられ、腕を拘束され、意味の分からないアラーム音に囲まれ、家族から引き離される——ICUの環境そのものが非人間化を生みやすい構造です [Wilson CritCare2019]。さらに脳症 (encephalopathy) により、患者は自分が置かれた痛みを伴う多数の刺激を理解しにくくなり、患者と家族はコントロールを手放さざるを得なくなります [Wilson CritCare2019]。ここが臨床医にとっていちばん見落としやすい点です——脳が正常に働いていれば「これは治療のためだ」と自分を納得させられる刺激も、せん妄やもうろう状態のもとでは、脈絡のない恐怖や暴力として体験されます。臨床医の側からは「必要な処置」に見える行為が、患者の側からは「説明のない暴力」として記憶に刻まれることがある、という非対称性がこの領域全体の出発点です。

非人間化は「悪意」からではなく「構造」から生まれる

非人間化は、個々の医療者が冷淡だから起きるものではありません。多数の患者を同時に管理し、生命維持を最優先する集中治療の構造そのものが、放っておけば非人間化に傾く力を持っています [Wilson CritCare2019]。だからこそ、次章以降で扱う評価・時刻表・記録という「仕組み」が対策の中心になります。

人間化は、これに対抗して人格・コントロール・尊重・プライバシー・支援体制を保つ組織的な取り組みを指します。当院の「Hotel ICU」はこの国際的な潮流の当院での名前で、スペイン発の HU-CI プロジェクトの人間化計画7領域と同じ方向を向いています [HU-CI CCM2020]。「人間化」という言葉自体は本来冗語ですが、それでも必要なのは、現実には非人間的なケアが起きるからです。

1-2. 苦痛の疫学 — 最も多い症状は何か

ICU患者が自分で報告できた症状を前向きに集めた多施設研究（ノルウェー2病院6 ICU、353名）の結果です [Saltnes-Lillegård ICM2023]。

表2 | 自己報告症状の有病率と強度 — 最多と最苦は別の症状

指標	症状	値
初日の有病率	口渇	66%
初日の平均強度	口渇	6.13 (95%CI 5.7–6.56)
7日間の有病率	口渇	64%
初日の平均苦痛度	不安	5.24 (95%CI 4.32–6.15)
侵襲的人工呼吸中の有病率	呼吸困難	約40%・VAS平均45mm

読み方は2段階です。「最も多くて最も強い」のは口渇ですが、「最も苦しい」のは不安です。強度だけで優先順位をつけると不安を取りこぼします。呼吸困難も疼痛に匹敵する苦痛で、原始的な恐怖反応を伴うため同定・予防・緩和が必須とされています [ERS/ESICM ICM2024]。この3症状（口渇・不安・呼吸困難）が、次章以降で評価と介入を詳しく扱う中心テーマになります。

1-3. 「頼まれたらやる」の限界 — なぜ良い意図が届かないのか

米国・準実験（最終解析103例、AJCC2019）は、両群に**同じ物品**（氷水スワブ・メントールリップ）を用意し、違いを「時刻表に載っているか」の1点だけにしました [VonStein AJCC2019]。

同じ物品・同じ人員

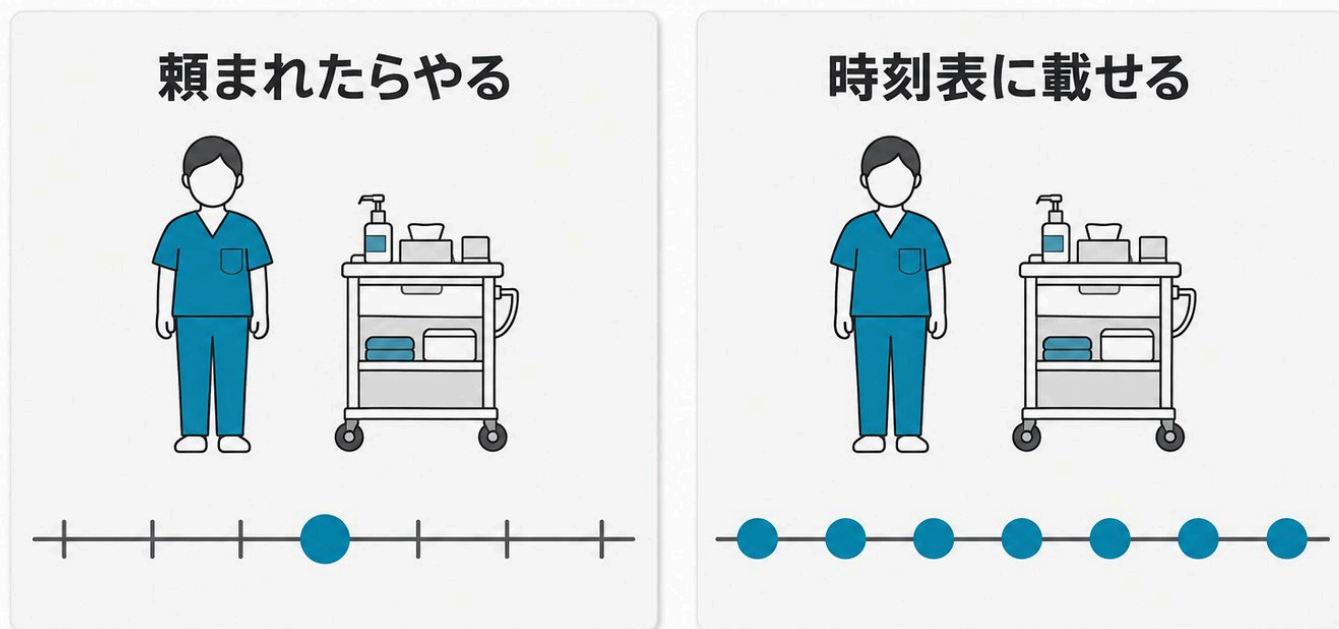


図1. 同じ物品・同じ人員でも、時刻表の有無だけで提供回数が変わる。

図の読み方 — 左＝依頼ベース（as needed）、7時間で丸印が1つ。右＝時刻を決めた運用、丸印が等間隔に並びます。丸印の数の差が、そのまま患者の体験の差になります。

表3 | 7時間の実使用回数 — 「頼まれたらやる」はほぼ提供ゼロに帰着する

物品	時刻表あり（介入群）	as needed（対照群）	P
氷水の口腔スワブ	5.4本	1.7本	<.001
メントールリップ保湿	4.4回	0.5回	<.001

対照群のリップ保湿は7時間で平均0.5回。悪意でも怠慢でもなく、ICUの7時間には優先度の高い仕事が無数にあるからです。**仕組みがなければ、良い意図はほぼ提供ゼロに帰着します**——これが本章の結論であり、この後に出てくるすべての介入（口渴バンドル・睡眠バンドル・Quiet Time・退室後訪問）に共通する設計原則です。

1-4. なぜ届かないのかを「個人」のせいにはしない — Hourglassモデル

看護研究のHourglass（砂時計）モデルは、コロンビアでの解釈学的現象学研究（成人16名への深層インタビュー）から、人間化を妨げる障壁を3層に配分します [Beltrán InvestEducEnferm2016]。図2のとおりです。



図2. 人間化を阻む障壁は3層構造（Hourglassモデル）。

図の読み方 — 上室の砂＝非人間的な志向を生む条件で、社会・法制度層／病院組織層／個人層に分かれます。くびれ＝人間化への努力。砂時計を支える脚が制度構造で、脚が細ければくびれをいくら磨いても砂は落ちません。

この研究はコロンビア・メデジンで2012年12月から2013年3月にかけて、過去に救急・重症疾患・手術で入院した経験のある専門職6名、入院患者の近親者7名、看護師3名の計16名への深層インタビューをもとにした解釈学的現象学研究です

[Beltrán InvestEducEnferm2016]。サンプルサイズは「情報の飽和（saturation）」——新しい面接をしても新しい主題が出てこなくなった時点——で決められています。原著の結論は「人間化されたケアと非人間的ケアの間には一方が他方を置き換える複雑な関係があり、社会・法制度／医療機関／看護師それぞれに依存する側面が影響する」というものです [Beltrán InvestEducEnferm2016]。タイトルの問い「人間的か非人間的かは、看護師が下す決断か」への答えは「看護師だけの決断ではない」です。この問いの立て方自体が重要です——「あの看護師は優しい」「この病棟は冷たい」という個人への評価に落とし込んでしまうと、砂時計の脚（制度構

造)を見過ごしてしまいます。研修医としては、自分の力だけでは変えられない構造があることを認めたくえて、それでも自分の持ち場でできる仕組みづくり(記録・時刻表・評価の習慣化)に集中するという姿勢が現実的です。アンゴラの質的研究(フアンボ州立総合病院ICU、看護職15名)でも「チームが揃っていなければ、人間化を行うことは不可能」と語られており [Sili RevBrasEnferm2023]、低資源環境ではむしろ技術習熟そのものが人間化の条件として並置されています——欧米型の「技術が人間関係を阻害する」という構図の反転です。研修医が現場で人間的ケアを実践できないとき、それは意欲の問題ではなく、砂時計の脚(人員配置・時間・記録の仕組み)が細いことが多いと考えてください。

1-5. 国際的な人間化の潮流とHotel ICUの対応

スペイン発の HU-CI プロジェクトは、2014年にブログでの「もし選べるなら、ICUはどうあってほしいですか」という問いに1万人超から提案が寄せられたことを出発点とし、エビデンスに基づく人間中心のICUモデルへのパラダイム転換を目指す国際研究プロジェクトです [HU-CI CCM2020]。人間化計画はオープンディア・コミュニケーション・患者のwell-being・医療者へのケア・PICS・人間化されたインフラ・終末期ケアの7領域と、160のアクションからなるグッドプラクティス・マニュアルにまとめられています。スペインとラテンアメリカの200超のICUが自己評価を提出し、グッドプラクティスの全体遵守率は40～60%でした [HU-CI CCM2020]——満点の施設は存在せず、どのICUも道半ばだということです。ただしこの遵守率は各施設の自己評価であり、第三者による監査ではありません。数字を額面通りに他施設と比較する材料にはできず、あくまで「完璧な施設はない」という相場観として受け取ってください。発想の源流はVincentらの「2050年のICUは5つ星ホテルのようになる」という未来像にあります [Vincent ICM2017]。

表4 | HU-CIの7領域と当院Hotel ICUの対応 — 外部の枠組みと当院の柱は一致している

HU-CI 7領域	当院 Hotel ICU の対応
オープンディア方針	面会緩和 (§6)
コミュニケーション	ケアラウンド・家族カンファ・つなぐシート (§6・§9)
患者のwell-being	口渇・睡眠・環境 (§3・§4・§5)
医療者へのケア	働きやすい環境・Wellbeing (§9の柱④⑤⑥)
PICS	退室後の連続ケア (§8)
人間化されたインフラ	家族支援ゾーン・面談室 (§6)
終末期ケア	死別後支援・臓器提供家族ケア (§6・§7)

この対応表が示すのは、当院のHotel ICUが独自の思いつきではなく、国際的な人間化の潮流の中に位置づけられるということです。次章からは、この7領域を「評価→口渇→睡眠→環境→家族→記憶と人格→退室後」の順に、研修医がベッドサイドで使える形に組み替えて見ていきます。順番の理由は単純です——まず何を測るかを決めなければ、どの介入が効いているかも分からないからです。評価を先に置き、そのあとで各論の症状・環境・家族に進み、最後に退室後という患者の時間軸に沿って章を並べています。

1-6. オープンディアICU — いちばん古くて、いちばん進んでいない領域

HU-CIの7領域のうち最初に置かれているのがオープンディア方針です。原著は「時間の柔軟化ないしオープンディアの確立が実行可能であり、患者・家族・専門職にとって有益である」という既存のシステムティックレビュー・メタ解析を引用し [HU-CI CCM2020]、面

会制限を「感染対策のため」と説明する慣習そのものを問い直しています。この領域は6章で扱う面会緩和のエビデンスと直接つながっており、当院がまず動かすべき柱の1つです。

人間化の定義（原著から）

HU-CIが引用するBermejoの定義は「健康を促進・保護し、疾病を治し、身体的・情動的・社会的・霊的な水準で健やかで調和のとれた生を支える環境を保証するために、なされるべきすべてのこと」です [HU-CI CCM2020]。人間化のもう一つの側面として、「専門職は誤りうるし脆弱である」と理解し受け入れることも挙げられています——専門職こそが医療を人間化する礎石だからです。

§2 評価とスクリーニング — 何を、誰に、どの尺度で聞か

この章で決めるのは、ラウンドで何をどの順番で聞か、そして各尺度を「使ってよい範囲」です。数字が出ることと、その数字が意味を持つことは別だと意識してください。

2-1. ベッドサイドで見る順番

体験を測る道具は、いま「揃った領域」と「まだ無い領域」がはっきり分かれています。ラウンドでの順番は次の4段です。

- 1. 口渴を NRS 2問で聞く（強度・苦痛の2つ）。自発的な訴えを待たない
- 2. 睡眠を毎朝 J-RCSQ の総得点で聞く。対象は非挿管・非鎮静・せん妄なしの患者だけ
- 3. 挿管患者は TOURS の4項目で well-being と安心感を取りに行く（手か頭の動きで回答できる）
- 4. 不安と呼吸困難は、まだ当院のラウンドに定型化されていません（後述）。最も苦痛度が高いのは不安であることを1章の疫学で確認しました

2-2. 口渴の評価 — 3層で設計する

口渴のClinical Evidence Review [AJCC2022]は、評価を3層に分けることを提案しています。第1層は毎勤務帯の口渴強度・苦痛 NRS 0-10（最も簡便）、第2層は口腔ケア時のmROAG（modified revised oral assessment guide、口唇・舌・粘膜の乾燥と亀裂を評価するチェックリスト）、第3層はICU退室時サンプリングのIPREA 18項目版（口渴・騒音・過度の光・睡眠剥奪・カテーテル不快・孤立を含むICU不快感の妥当性検証済みツール）です。ただし第2層には注意が要ります——口腔の湿潤度だけでは口渴強度を信頼して予測できないと同レビューは明記しており [AJCC2022]、日本のICU 86例の観察研究でも口渴NRSと口腔水分計の相関は $\rho=-0.01$ ($p=0.96$) と無相関でした [Doi ICNS2021]。「口が湿っているから渴いていない」と判断しないでください。

表5 | 口渴の評価3層 — 層ごとに役割が違う

層	ツール	頻度	注意点
第1層	口渴強度・苦痛 NRS 0-10	毎勤務帯	最も簡便。5点以上で介入対象
第2層	mROAG	口腔ケア時	湿潤度だけでは口渴強度を予測できない
第3層	IPREA 18項目版	ICU退室時サンプリング	ユニット単位の快適さPDCA指標になる

同じ観察研究で、口渴のあった患者のうち**自発的に訴えたのは20%だけ**、聞けば70%が答えました [Doi ICNS2021]。約80%の口渴は、こちらから聞かない限り「存在しない症状」になります。認識のギャップは看護師側にもあります——重症ケア看護師への調査では、回答者の半数以上が「人工呼吸が口渴と関連する」ことを認識しておらず、口渴緩和のケア計画を報告した者はごくわずかでした [AJCC2022]。

2-3. 睡眠の評価 — 対象を間違えない

睡眠測定は「測る次元」によって使える道具が変わります。62研究のシステマティックレビューが推奨するのは**SOT (Sleep Observation Tool) とRCSQの2つだけ**で、BIS/SedLineもアクチグラフも推奨されません [Richards FrontNeurol2020]——不動のICU患者では脳波・体動由来の指標が睡眠を過大評価するためです。

表6 | 評価尺度の比較 — 検証された対象を外すと数字は意味を失う

尺度	何を測るか	検証された対象・性能	使い方の線引き
口渴 NRS 2問	渇きの強度・苦痛	軽度0-4／中等度5-6／重度7-10	✔ 毎日全例に。5点以上で介入対象
J-RCSQ (RCSQ日本語版)	患者が知覚した睡眠	非挿管33例。α 0.911、PSG睡眠効率と r=0.602 (ICDSC≤2の29例)	✔ 総得点のみ。挿管・深鎮静・せん妄患者は対象外
SOT (Sleep Observation Tool)	観察による睡眠	PSGと一致率81.9%だが覚醒回数は観察8.5／PSG40＝目視の約1/5	⚠ 観察の主観アウトカムに使ってよいが主要評価には使わない
BIS／SedLine・アクチグラフ	脳波・体動由来の睡眠	睡眠段階の一致は低く、覚醒検出特異度も低い	✖ 推奨しない（不動のICU患者では睡眠を過大評価する）
TOURS Scale	挿管患者の well-being と安心感	フランス4 ICU、84例。α 0.83、実施不能13%。元患者・家族と共同開発	✔ 挿管患者に1日2回以上
Faces Anxiety Scale	不安	挿管・非挿管の双方で妥当性検証済み	⚠ PADIS 2025が選択肢として挙げるが管理への推奨はまだない

J-RCSQ が検証されたのは非挿管33例、内部一貫性α 0.911、PSG睡眠効率との相関r=0.602 (ICDSC≤2の29例に限定) です [Murata NursOpen2019]。この表で最も大事なのは右端の列です。J-RCSQを挿管患者に使えば数字は出ますが、検証された使い方ではありません。**数字が出ることと、その数字が意味を持つことは別です。**

2-4. 挿管患者のwell-being — TOURS Scale

話せない患者の体験をどう測るかは、この領域で最も遅れていた課題でした。TOURS Scale はフランス4 ICUで系統的レビュー・フォーカスグループ（元患者23名・家族5名）・3ラウンドのデルファイ（医療者23名・研究者6名・患者家族35名）を経て開発され、84例のコホートで検証されています [TOURS CritCare2026]。最終的な4項目版は身体的安心感・情動的well-being・関係のwell-being・情動的安心感の次元で構成され、**CFI・TLI ともに0.99超、RMSEA 0.02、Cronbach α 0.83**という良好な心理測定特性を示しました。305回の実施のうち284回（93%）が完遂し、39回（13%）は実施不能でした——「実施不能」もデータとして記録する設計です。もともとの候補にあった「不安」項目は6項目版の検証段階で不適合として削除されており、**不安は依然として別の評価が必要だ**と分かります。

開発の過程を知っておくと、この尺度への信頼度が変わります。系統的レビューで883件から137件（15%）を採択してワードクラウドを作り、元患者23名・家族5名のフォーカスグループで「挿管中のコミュニケーション・情報提供の不足」「人としての存在と人間的支援の必要性」という2主題を抽出し、医療者23名・研究者6名・患者家族35名による3ラウンドのデルファイで次元と項目を絞り込んでいます [TOURS CritCare2026]。開発の初期段階から**元患者・家族が意思決定に参加している**点が、この領域の他の尺度と一線を画します。

TOURS運用のこつ

回答は手か頭の動きでよく、発声を必要としません。**1日2回以上**を目安に、実施できなかった回は「実施不能」とだけ記録してください。ゼロにする必要はなく、「測れなかった」という記録そのものが、後で振り返るときの診断材料になります。

2-5. 不安と呼吸困難 — まだ道具が追いついていない領域

PADISガイドラインの2025年改訂は「不安」を新しい対象領域として立てましたが、**推奨は1つも出せませんでした**——エビデンスが皆無だったためです [PADIS CCM2025]。Faces Anxiety Scaleが実用的な選択肢として挙げられていますが、管理への推奨には至っていません。同じ改訂でICUサバイバー3名が正式パネルメンバーに参加しており、元患者を尺度開発とガイドライン作成の場に座らせるのがこの領域の新しい標準です。呼吸困難については、人工呼吸を受けている重症成人患者の約40%が経験し、VAS平均45mmという疼痛に匹敵する強度が報告されています [ERS/ESICM ICM2024]。同合同声明は、呼吸困難が原始的な恐怖反応を伴う独立した苦痛であり、同定・予防・緩和が必須と明記しています。当院のラウンドにはまだこの2つを定型評価する仕組みがなく、これは今後の課題として残ります。

Faces Anxiety Scale の使い方

5段階の表情イラストを患者に指差してもらい、非言語で答えられる尺度です。挿管・非挿管の双方で妥当性検証済みですが、管理（治療介入）への推奨はまだありません [PADIS CCM2025]。「不安が強そうだ」という印象を、この尺度で言語化する使い方が現実的です。

発声できない患者の呼吸困難を捉える手段としては、頻呼吸・鼻翼呼吸・呼吸補助筋の使用・奇異呼吸といった観察所見を組み合わせた行動指標が研究レベルで存在しますが、当院のラウンドにはまだ組み込まれていません [ERS/ESICM ICM2024]。コミュニケーション可能な患者には「息は苦しいですか」とVASまたは0-10のNRSで一言尋ねるだけでも、何も聞かないよりはるかに多くを拾えます。

2-6. 「測れない患者」を「測れたこと」にしない

自己申告できない患者はICU患者の最大1/2にのぼります [Richards FrontNeurol2020]。せん妄・鎮静のためにJ-RCSQもTOURSも実施できない患者に対して、無理に数字を出そうとしないでください。「誰が測れなかったか」を必ず記録するのが作法です。この原則は、次章以降で扱う口渴バンドル・睡眠バンドルすべてに共通します——測定の空白を埋めようとして、検証されていない使い方に手を出さないことが、この領域でいちばん見落とされやすいピットフォールです。

2-7. 退室時サンプリング — IPREAとTDSの中身

2章冒頭で触れたIPREA（Inconforts des Patients de Réanimation）18項目版は、ICUに関連する18の不快感をNRS 0–10で評価する妥当性検証済みツールで、口渇・騒音・過度の光・睡眠剥奪・カテーテル不快・孤立などを含みます [AJCC2022]。1人1人に毎日使うものではなく、ICU退室時に一部の患者へサンプリングし、ユニット単位の快適さマネジメントの出来を測る位置づけです。

口渇に特化した尺度としては、口渇の不快感を12項目3因子で測るThirst Discomfort Scale（TDS）が外科患者198名で開発・妥当性検証されています。ただしICU・挿管患者では未検証でカットオフも定まっていません。当院で口渇の重症度を線引きする際は、TDSではなくPuntillo基準（NRS 0–4軽度／5–6中等度／7–10重度）を使ってください [AJCC2022]。

表7 | 退室時サンプリングの2つの道具 — 毎日使う道具と使い分ける

ツール	項目数	対象	当院での使い方
IPREA 18項目版	18（NRS 0–10）	ICU患者全般	退室時に一部の患者へサンプリング。ユニット単位のPDCA指標
Thirst Discomfort Scale（TDS）	12（3因子）	外科患者で開発。ICU未検証	当院では使わない。口渇の重症度はPuntillo基準を使う

§3 口渇と口腔ケア — この領域で最もエビデンスが揃う

口渇はICUで最多かつ最強の自己報告症状であるにもかかわらず、長く「快適さの話」として軽視されてきました。この章では、なぜ口渇が起きるかという生理から、リスク因子、6研究の介入エビデンス、当院の実装プロトコルまでを一気通貫で扱います。

3-1. 口渇の生理学 — なぜ渇くのか

口渇はナトリウムと水のバランスに関わる恒常性維持機構で、浸透圧性と循環血液量減少性の両方によって生じます [AJCC2022]。ICUで問題になるのは主に前者です——循環血液量減少による口渇には血液量の10%減少が必要なのに対し、高浸透圧は少しの細胞脱水で血漿浸透圧を上げ、抗利尿ホルモンを介した代償が効かないときに口渇の感覚を生じさせるからです [AJCC2022]。この生理を理解しておくと、「飲水させれば渇きは取れる」という発想が、絶飲食下のICU患者には使えない理由が分かります。渇きを止める手段は、水を飲ませることではなく、口腔内の受容体を局所的にだますことになります。

冷刺激とメントールが効くのはここに理由があります。口腔内に広く分布する冷受容体TRPM8（transient receptor potential melastatin 8）が冷たさやメントールで活性化するとカルシウムチャンネルが開き、三叉神経・舌咽神経の自由神経終末を介して帯状回のBrodmann 3-2-1野へ投射し、「吸収前満腹感（preabsorptive satiety）」という中枢の機構が生じます [AJCC2022]。水を飲んでいないのに渇きが和らぐのは、この機序によるものです。冷刺激とビタミンCスプレーは唾液分泌も刺激し、口腔粘膜を潤して口渇知覚をさらに下げます。「氷とメントールにはちゃんと神経生理学的な根拠がある」と説明できると、現場の納得度が変わります。

もう1つ知っておくべき背景があります。浅い鎮静や毎日の鎮静中断への移行により、人工呼吸患者の口渇体験はむしろ高頻度になっている可能性があると原著は指摘しています [AJCC2022]。深い鎮静で症状を感じにくしていた時代から、浅い鎮静で意識清明な時間が増えた今、口渇ケアの重要性はむしろ増していると理解してください。ABCDEFバンドル（8章）で覚醒トライアルを推進するほど、口渇を訴えられる患者が増えるという副産物が生じます。

3-2. リスク因子 — 先回りできるものが多い

口渇のClinical Evidence Reviewは、口渇リスク因子を診断・検査・薬剤・治療・患者背景の各カテゴリーで整理しています [AJCC2022]。特に薬剤要因は当院で今日から見直せます。

表8 | 口渇のリスク因子 — 薬剤は今日から見直せる

カテゴリー	因子
薬剤	フロセミド >60mg／オピオイド >50mg／NSAIDs／ステロイド／降圧薬／抗コリン薬／PPI／SSRI／三環系抗うつ薬／利尿薬 >100mg
治療	絶飲食（NPO）／人工呼吸／加温加湿ベンチュリーマスク
検査値	高Na血症／低イオン化Ca／負の水分バランス
診断・患者背景	APACHE IIスコアが高い／消化器疾患／口腔乾燥症／男性／重症度が高い

ICU回診チェックリストに「口渇ハイリスク薬の有無」を1行入れるだけで、渇かせている原因に手が届きます [AJCC2022]。人工呼吸中の口渇は「圧倒的」で存在的な苦痛だとする質的研究（意識のある12名）の語りとも符合します——口渇は疼痛・恐怖・孤立・睡眠剥奪・寒さと同じくらい強い、絶え間ない体験だと患者は表現します [AJCC2022]。

⚠ 看護師側の認識にもギャップがある

重症ケア看護師への調査では、回答者の半数以上が「人工呼吸が口渇と関連する」ことを認識しておらず、口渇緩和のケア計画を報告した者はごくわずかでした [AJCC2022]。当院でプロトコルを始める前に「人工呼吸中の患者は口渇を感じますか」という1問だけのアンケートをスタッフに取ってみると、導入の推進力になります。

3-3. 介入エビデンス — 6研究の統合、level B

Clinical Evidence Reviewは、PICO「重症ケア看護師は口渇の強度と苦痛の緩和にどのような介入を使えるか」に対し、観察研究1・前後比較1・準実験1・RCT 3の計6研究を統合し、AACNのエビデンスレベルで総合判定level B（十分にデザインされた対照研究で一貫して支持）としました [AJCC2022]。level A（メタ解析・システムティックレビュー）ではないことに注意してください。

表9 | 口渇介入6研究の主要結果 — 効果は出るが「消えない」

研究	デザイン・n	主要結果
Doi 2021	観察・N=86	口腔ケアで口渇強度6.0→5.0 (P<.05) だが 1時間で戻る
Lemyze 2020	前後比較・N=26	ミント氷キューブ3個で 5分以内に 強度8.5→4.0 (P<.001)
Zhang 2021	RCT・N=61	ビタミンC口腔スプレー等のバンドルで強度6.69→5.42 (対照6.93、P<.001)
VonStein 2019	準実験・N=103	時刻表化バンドルで強度-2.84 vs -1.68 (P=.02)
Kalfon 2017	クラスターRCT・34 ICU	テーラーメイド多要素介入で強度 2.32 vs 3.40、P<.001
Puntillo 2014	RCT・N=252	1日3回15分のセッションで強度5.9→3.6 (対照5.3→4.7、P<.01)

効果の大きさの相場観は、即効性介入で強度1.0～4.5点・苦痛1.8～3.0点の低下、バンドル介入は**効果がより長く続くが弱い**（強度1.27～2.83点）です [AJCC2022]。どの研究でも口渇は消えず、最終値は軽度～中等度（2.0～5.0）に留まります。「ゼロにする」ではなく「重度を中等度以下に下げ続ける」が現実的な目標です。

⚠ 因果を言わない・エビデンスの強さを盛らない

「24時間を超えて持続する強い口渇はせん妄リスクの上昇と関連」「1年後のPICSと関連」という記載はすべて**関連であって因果ではありません** [AJCC2022]。加えて口渇のMCID（臨床的に意味のある最小変化量）は確立されておらず、採用研究の多くが人工呼吸患者をほとんど含んでいません（Zhang研究は非挿管、VonStein研究は挿管患者2名のみ）。当院の中心である挿管患者への外挿はまだ確証がなく、提案文は「level Bのエビデンスがある、日常のケアラウンドに組み込める」までにとどめてください。

3-4. 実装プロトコル — 当院の時刻表と家族の巻き込み方

口腔ケアの効果は1時間で戻るため、口渇バンドルは**1時間ごと**のスケジュール実施が本体です [Doi ICNS2021]。日中10～17時の毎正時を目安に、氷水スワブとメントールリップ保湿を行い、実施回数を記録してください。即効性が必要な場面ではミント氷キューブ3個が5分以内に効きます [AJCC2022]。

表10 | 当院の口渇プロトコル早見 — 何を・いつ・どう記録するか

場面	介入	頻度・記録
日中の定期ケア	氷水スワブ＋メントールリップ保湿	10～17時の毎正時。実施回数を記録
即効性が要るとき	ミント氷キューブ3個	5分以内に強度低下。都度記録
NRS 5点以上	介入対象として時刻を決める	デイリーゴール・回診で共有
面会時	家族による口腔ケアの実施	希望する家族に手技を教え、参加を促す

本レビューは「簡単な口腔ケアを行いたいと考えている家族を巻き込むことも、快適さのニーズを定期的に満たすための選択肢の1つ」と述べています [AJCC2022]。面会時に家族が氷水スワブとリップ保湿を行える運用は、家族の「何もしてあげられない」という無力感を減らす最も低コストな施策でもあります——本症例で奥さんが漏らした「私も何もしてあげられなくて」という言葉に、そのまま応える一手になります。

絶飲食＝何もできない、ではない

嚥下評価前や術後の絶飲食は「口から水分を入れない」という指示であって、「口渇ケアをしない」という指示ではありません。氷水スワブ・メントールリップ・口腔ケアは、水分の嚥下を伴わないため**絶飲食下でも継続できます**。この区別を看護師・研修医の双方が理解していないと、絶飲食の間ずっと口渇が放置されることになります。

評価結果を組織の仕組みに乗せる

強度の高い評価結果をデイリーゴール・チェックリストに組み込み、ユニット回診で議論してください [AJCC2022]。ICU退室時に一部の患者へIPREA簡易評価を行えば、「自ユニットが症状全体をどれだけうまく管理できているか」を測る指標になり、継続的改善のPDCAにそのまま使えます。

3-5. レビューの検索方法と限界 — どこまで信じてよいか

Clinical Evidence Reviewは、CINAHL・PubMed・UpToDate・Cochrane Reviews・TRIPをキーワード「thirst, critically ill, intensive care, interventions」で検索し、原著研究に限定して6件を採用しています [AJCC2022]。PRISMA等の報告ガイドラインへの準拠は明記されておらず、検索式・スクリーニング件数・バイアスリスク評価の記載也没有。単著によるナラティブ寄りの統合で、プールした効果推定値（メタ解析）は算出されていません。示されているのは各研究の点推定値の「幅」だけです。研修医として押さえておくべきは、**これはシステマティックレビューではない**という一点です。level Bという判定も、AACNのエビデンスレベルリングシステム（Peterson らによるA～E+Mの6段階）に基づく1人の著者の判断であり、複数レビュアーによる合議ではありません。

研修医が説明で使ってよい表現・使ってはいけない表現

使ってよい：「1時間ごとの口渇バンドルはlevel Bのエビデンスがあり、日常のケアラウンドに組み込める」。使ってはいけない：「口渇ケアでせん妄が1年後のPICSが減ることが証明されている」——これは関連研究の飛躍した引用であり、原著も「関連」としか述べていません [AJCC2022]。

§4 睡眠と概日リズム — なぜ眠れないかを先に理解する

この章では、ICUで眠れない理由を生理から説明したうえで、評価の対象を線引きし、薬物介入のエビデンスが軒並み弱い理由を確認します。結論を先に言うと、この領域で確実に効くのは薬ではなく環境の整え方です。

4-1. なぜ眠れないと害になるのか — グリンパティック系という仮説

「眠っているように見える時間」と「回復に必要な睡眠」は別物だという仮説が近年注目されています。徐波睡眠中は皮質のノルアドレナリン放出が下がって閾質腔が最大60%広がり、脳脊髄液が動脈周囲を流れてアミロイドβやリン酸化タウを洗い流す**グリンパティック系**が働くとされます [CritCareSci2026]。この仮説の要点は、短時間の覚醒が入るだけで流れが止まってしまうことです——総睡眠時間が保たれていても、断片化そのものが害になるという主張です。実務への含意は「静かにする」ことより、「夜間にまとまって触らない時間を作る」ことにあります。この考え方は5章で扱う光の実測データ（夜間中央値0 luxでも20 lux超のイベントが1時間に7～16回起きる）と接続します——グリンパティック系の仮説が正しければ、平均照度がどれだけ低くても、断片化するイベントの回数そのものが害の大きさを決めることになります。ただし注意が必要です。ヒトのICU患者でグリンパティック機能を実際に測った研究も、睡眠を改善して認知予後が変わったという介入データも存在しない、純粋な仮説段階の理論です [CritCareSci2026]。使えるのは「なぜ断片化を避けるべきか」という説明の言葉までで、施策の効果の根拠にはできません。

4-2. 評価 — 対象を線引きする

睡眠評価の道具立ては2章で扱った通りで、**J-RCSQ の総得点**が非挿管・非鎮静・ICDSC≤2の患者に限って使えます [Murata NursOpen2019]。挿管・深鎮静・せん妄患者には検証された評価手段がまだありません。この空白を埋めようとしてBIS/SedLineやアクチグラフに手を出さないでください——不動のICU患者では睡眠を過大評価することが62研究のシステマティックレビューで示されています [Richards FrontNeurol2020]。

4-3. 薬物介入のエビデンス — なぜ弱いのか

単独の薬物介入は軒並み期待外れです。ICUの概日リズム医学に関するWhat's Newは、日中の高照度光734名・予防的メラトニン847名のいずれも大規模RCTで陰性だったとまとめています [ICM2023]。より新しい睡眠覚醒調節薬（ラメルテオン・スボレキサント・レンボレキサント）のシステマティックレビュー・メタ解析（24研究4489例）では、せん妄の有病率がRCTでRR 0.60（95%CI 0.38–0.97）、観察研究でRR 0.54（0.43–0.68）と有意に減りましたが、いずれも確実性は**低い**と判定され、人工呼吸日数・退院時死亡・在院日数・ICU在室日数には有意差がありませんでした [CCM2025]。

表11 | 睡眠覚醒調節薬SR・MAの主要結果 — **せん妄は減るが確実性は低い**

デザイン	せん妄への効果	確実性	副次アウトカム
観察研究	RR 0.54 (0.43–0.68)	低	人工呼吸日数・死亡・在院日数・ICU在室日数はいずれも有意差なし
RCT	RR 0.60 (0.38–0.97)	低	

薬剤種類・年齢・セッティング・投与期間で交互作用のp値はすべて0.10以上で、どの患者に・どの薬が効きやすいかを示すデータはありません [CCM2025]。著者ら自身が「臨床実践の変更をまだ支持しない」と明記しており、この一文を鵜呑みにしてルーチン処方に踏み切らないことが重要です。日中の高照度光が734名の大規模RCTで陰性だったからといって、日中の光曝露そのものが無意味というわけではありません。光は概日リズムを合わせる（entrainment）ための入力の一つであり、単独の治療介入として評価すると効果が見えにくくなります——5章で扱う環境バンドルとして設計する理由がここにもあります。

⚠ 薬から入らない

環境を整えても眠れない高リスク患者に対して、まず睡眠覚醒調節薬を検討したくなりますが、順序を間違えないでください。
非薬物的な引き算（音・光）が先、薬は最後——次章で扱う環境介入を先に試し、それでも眠れない場合の代替としてのみ検討します。全例への予防的定期処方はしません。

4-4. 記憶への影響 — 深鎮静と妄想的記憶

睡眠と鎮静の話は、記憶の問題にも直結します。オランダ²施設・426例の多施設縦断コホートでは、ICU退室後の妄想的記憶が38.5%に生じ、その6割近くはせん妄と診断されていませんでした [ICM2025]。妄想的記憶を持つ患者だけがPTSD症状を3か月後6.7%から12か月後18.1%へと有意に増やし、事実記憶しか持たない患者が最もPTSD症状が少ないという結果でした。完全健忘に関連したのは女性（aOR 1.99）と深鎮静日数（aOR 1.34／1日あたり）です [ICM2025]。ここで重要なのは、**健忘にしてもPTSDは減らない**という事実です——「記憶を消すための鎮静」は、この結果からは正当化されません。妄想的記憶を減らすには、鎮静を深くすることではなく、せん妄そのものの予防と、断片化しない夜間環境が優先されます。

4-5. 耳栓・アイマスクという個人向け遮蔽具の位置づけ

耳栓とアイマスクは、環境の引き算をしたあとに追加する「個人向け」の遮蔽具です。術後高依存治療室での耳栓・アイマスクの睡眠への効果を検証した研究はありますが、結果の記載が乏しく、単独介入としての効果量を明言できるほどの強いエビデンスにはなっていません。低用量クロニジンで術後の睡眠時間が延びたとする報告もありますが、著者自身が測定機器の妥当性に留保を付けています。**個人向け遮蔽具は「引き算をしたうえでの追加」であって、引き算の代わりにはなりません**——アラームが鳴り響く部屋で耳栓だけ配っても、音源そのものは減っていないからです。

4-6. 実装 — Quiet Timeと環境の引き算

Quiet Timeは夜間21:00～翌6:00に、頭側1mのアラーム音量・モニター輝度を先に下げる運用です [当院 Hotel ICU]。順序は「引き算が先、耳栓・アイマスクは後」——次章で扱う環境データが示すとおり、まず音源・光源そのものを減らし、それでも足りない場合に個人向けの遮蔽具を追加します。単独の環境介入は大規模RCTで陰性が続いているため、**経営会議で「せん妄が減ります」と約束しない**のが誠実な姿勢です。約束できるのは環境指標の改善までで、その先は次章で詳しく扱います。

表12 | 睡眠介入の相場観 — 単独介入はどれも陰性が低確実性

介入	規模	結果
日中の高照度光	734名	陰性
予防的メラトニン	847名	陰性
睡眠覚醒調節薬（3剤）	24研究4489例	せん妄RR 0.54～0.60、確実性は低い
Quiet Time＋環境の引き算	当院運用	単独の転帰改善データはなし。環境指標としてのみ評価

研修医が説明するときの言い方

「眠れるように調整しましょう」だけでは何も決めていません。**まず音と光を引き算し、それでも眠れなければ薬を検討する、**という順序を家族にもそのまま伝えてください。順序を明示することが、過剰な睡眠薬処方を防ぐいちばん簡単な方法です。

§5 環境 — 音と光は「引き算」から

ICUの音と光は、数十年にわたって国際基準を大きく超えたまま変わっていません。この章では、なぜ変わらないのかという構造の問題と、最近の連続実測が明らかにした「平均値では見えない」実態を扱い、当院で今日から確認できることを示します。

5-1. 騒音の実測 — 数十年変わっていない理由

2000年から2025年までの英語文献を対象にしたナラティブレビュー（25研究の実測を要約）は、ICUの音が平均44～66.5 dBA・ピーク62.5～127.9 dBAで、WHO推奨（昼平均35 dBA・夜最大40 dBA）の1.5～2倍のまま数十年変わっていないと報告しています [CritCareResPract2026]。問題は音の大きさそのものより、**予測不能で高周波のピークが夜も減衰しないこと**です。健常成人は昼50～55 dBA・夜40～45 dBAまでなら不快感なく耐えられますが、30 dBAを超える持続曝露と45 dBAのピークで睡眠の質が損なわれ、80 dBAを超える音は皮質性覚醒を引き起こします [CritCareResPract2026]。HPA軸と交感神経が活性化し、コルチゾール・心拍数・酸素消費量・鎮静薬必要量が上昇し、メラトニンリズムが乱れます。

音源マッピング研究は、この問題を「どこを直すか」という設計の問題に変えました。4床室で248日間・1225万点の音源位置をマッピングした研究です [Darbyshire Anaesthesia2019]。

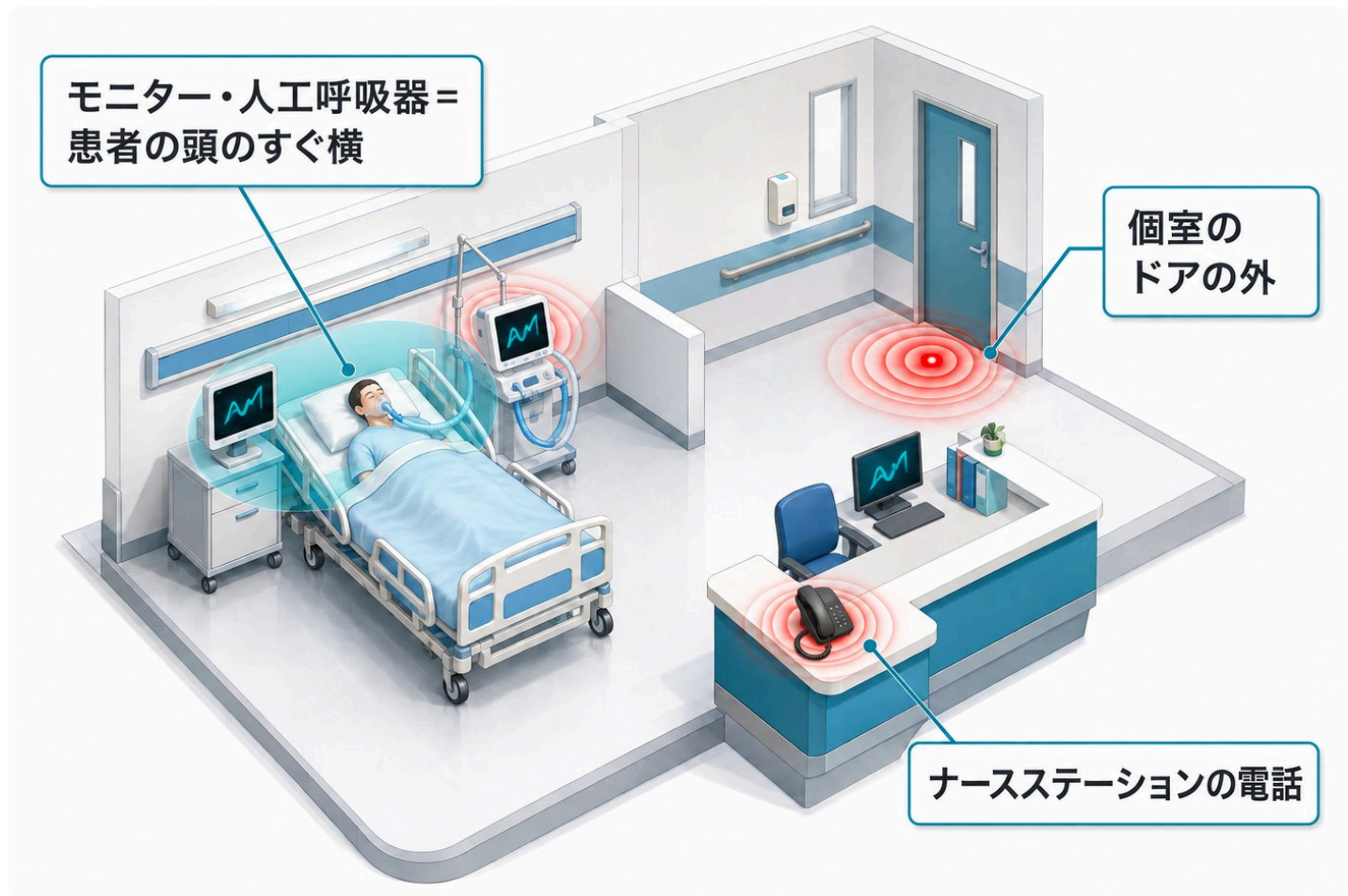


図3. 大きな音の発生源は3か所に集中していた。

図の読み方 — ①各ベッドのモニター・人工呼吸器＝患者の頭のすぐ横、②優先使用される個室のドアの外、③ナースステーションの電話。「ICU全体を静かに」より「ベッド頭側1メートルの音源を潰す」ほうが効きます。本研究は音の種別を同定できておらず、患者アウトカムも測っていません。

5-2. 光の実測 — 問題は暗さではなく断片化

オーストリア・グラーツの3つのICUで、患者の眼の高さで5秒ごとに1年間照度を記録した研究があります（222名、1,457万回）[CritCare2026]。昼間の照度中央値は**86.5 lux**（オフィスの目安300～500 luxを大きく下回る）、夜間は**0 lux**でした。ここまでは「暗すぎず明るすぎない、むしろ暗い」という印象を与えますが、実態は違います。この「暗い夜」に20 lux超の光イベントが**1時間あたり7～16回**起き、5分以上途切れない暗闇は夜間の67.8～78.8%にとどまっていました [CritCare2026]。この断片化のパターンは部屋の種類・侵襲的人工呼吸・非侵襲的換気・腎代替療法のいずれとも有意な関連がなく、著者は**ICUの光はケアプロセスの構造的副産物である**と結論しています。

測っていないもの

この研究はメラトニン・深部体温などの概日バイオマーカー、睡眠の質、せん妄、患者転帰、そして光のスペクトル（メラノピック照度、概日リズムへの影響が強い青色光の成分）をいずれも測定していません [CritCare2026]。「照度が低い＝概日リズムへの影響も少ない」とは限らず、スペクトルの影響は今後の課題です。

表13 | 音と光の実測2本の対比 — 平均値・中央値は環境問題を隠す

	音 (Anaesthesia2019)	光 (CritCare2026)
規模	4床室・248日・1225万点	222名・1年・1457万回
「平均は正常」に見える点	患者アウトカムは未測定	夜間中央値0 lux
実態を明かした指標	音源の位置（頭側1m・ドア外・電話）	20 lux超イベント：1時間7～16回
出すべき指標	イベント回数（単一マイク1点）	まとまった暗闇の割合（67.8～78.8%）

両者は同じ結論に着地します——「平均値・中央値は環境問題を隠す。出すべきは閾値超のイベント回数と、途切れない静穏／暗闇の割合」です。当院で環境測定をするなら、この2本と同じ指標で出すと他施設と比較できる形になります。

5-3. 介入エビデンス — 単独では陰性が続く

単独の環境介入は大規模RCTで陰性が続いています。日中の高照度光734名・予防的メラトニン847名のいずれも陰性でした [ICM2023]。患者中心のベッドスペース設計に関する提言は、照明・音響環境の改善は示せても**患者転帰は今後の評価課題**だと著者自身が明記しています [CritCare2023]。ナラティブレビューが示した数少ない持続的な成功例はSLEEPバンドル（睡眠の質改善とせん妄発生20%低減）ですが、多くの介入は追跡期間が短く、強化が途切れると効果が減衰します [CritCareResPract2026]。多成分介入が単独介入より持続しやすい理由は単純です——1つの要素が形骸化しても他の要素がまだ機能しているため、システム全体としての効果が急には失われないからです。当院の音・睡眠プロジェクトも、耳栓の配布だけといった単一の施策に頼らず、測定・アラーム調整・Quiet Time・教育を組み合わせで設計してください。

⚠ 約束できるのは「環境指標の改善」まで

経営会議で「音や光を整えればせん妄が減ります」と言わないでください。言えるのは「PICSの一次予防としての上流対策」という筋までです [SingaporeMedJ2026]。単発の掲示・静穏時間・教育は一過性に終わり、持続する改善は多成分・システムレベルの取り組みでしか観察されていません [CritCareResPract2026]。

5-4. 実装 — 今日確認できることと、測り方の指針

音源マッピング研究には、今日すぐ確認できることが1つあります。研究施設ではモニターのアラーム音量が電源投入時に標準値へ戻り、看護師は調整できたのに実際にはほとんど行われていませんでした [Darbyshire Anaesthesia2019]。当院の機種が同じ挙動をするかを確認するのに、購買も改修も不要です。ナラティブレビューが示すアラーム個別化の効果は15～35%の音量低減、吸音天井タ

イルなど建築的介入は5～10 dBA低減です [CritCareResPract2026]——ただし建築的介入は予算と時間を要するため、当院ではまずアラーム個別化と測る仕組みの整備が現実的な一手になります。

表14 | 環境測定的设计 — 他施設と比較できる形にする

測るもの	指標	頻度
騒音	LAeq+Lmax+イベント回数（患者頭部近くに単一マイク1点）	定点1週間、1・6か月後に再測定
光	夜間のまとまった暗闇の割合（20 lux以下が5分以上連続）	同上
併記する臨床指標	RCSQ総得点・せん妄評価	測定期間と同時併記

だから打ち手は「調光」「アイマスク」「Quiet Time」をバラバラに評価せず、バンドルとして1つの体験として設計してください [ICM2023]。1人の患者から見れば、音も光も睡眠も分かれていません。まとめたほうが説明も測定も楽になります。

5-5. 音の発生源とスタッフへの影響 — 経営会議で使える論点

ナラティブレビューは音源を4つに整理しています——機器アラーム（人工呼吸器・モニター・輸液ポンプ）、スタッフの会話と活動（申し送り・処置・体位変換）、外部環境（廊下・休憩室）、そして建築設計（オープンレイアウト・反射性の硬い表面）です [CritCareResPract2026]。患者の重症度が高いほど室内の環境音レベルが高いという観察もあります。見落とされがちなのは**スタッフ側への影響**です——語音明瞭度・記憶・注意の低下、申し送りの分断、中等度の背景音でも本人が自覚しないまま認知疲労とエラー率が上がることが報告されています。慢性的な曝露は情動的消耗・易刺激性を通じてバーンアウトに寄与します。「音を減らすのは患者のため」だけでなく「スタッフの安全のため」という説明も、経営会議では有効です。

表15 | 介入の効果量（ナラティブレビューより） — 強化が途切れると効果が減衰する

介入	効果量	持続性
吸音天井タイル・空間再配置	5～10 dBA低減	建築的介入のため持続する
アラーム個別化	15～35%低減	設定の見直しが必要
構造化された教育キャンペーン	平均7 dBA低減	一過性。強化が途切れると戻る
SLEEPバンドル（多成分）	せん妄発生20%低減	多成分・システム介入のため持続

結論は明快です——ICUの音が変わらないのは認識不足のためではなく、文化的規範（騒がしさを「見守っている証」、静けさを「放置」と受け取る）、建築的制約、行動介入の持続性の低さが重なった結果です [CritCareResPract2026]。説明責任・ベンチマーク・担当者・定期モニタリングという制度的な仕掛けがない限り、変化は続きません。当院の音のプロジェクトも、単発のキャンペーンで終わらず、定点測定を継続する仕組みとして設計する必要があります。

5-6. 基準値の読み方 — WHOとEPAで数字が違う

「ICUは何dBAを目指すべきか」という問いに対し、しばしば異なる2つの基準値が引用されます。WHO（Guidelines for Community Noise, 1999）は一般病室で昼間平均35 dBA以下・夜間最大40 dBA未満とし、米国EPA（1974）は昼45 dBA・夜

35 dBAとしています [CritCareResPract2026]。EPAのほうがやや緩い基準です。当院で目標値を掲げるときは、どちらの基準を採用しているかを明記してください——「WHO基準では」と「EPA基準では」を混同すると、達成率の見え方が変わってしまいます。

表16 | 基準値の比較 — どちらを採用するか明記する

基準	昼間	夜間
WHO（1999）	平均35 dBA以下	最大40 dBA未満
米国EPA（1974）	45 dBA	35 dBA
実測（25研究の要約）	平均44～66.5 dBA・ピーク62.5～127.9 dBA	

どちらの基準で見ても、実測値はいずれも大きく超過しています。Quiet Timeの効果についても数値があります——静穏時間帯は、そうでない時間帯に比べて患者が睡眠している確率が高くなるという報告があり、時間帯を区切ること自体に一定の根拠があります [当院 Hotel ICU]。ただしこれも単独介入としての大規模な効果検証ではなく、環境整備の一部として位置づけてください。

§6 面会と家族中心ケア — 家族は「支援される対象」であり「対処資源」でもある

この章は分量が多くなります。理由は単純で、この10年でランダム化比較試験が最も蓄積した領域だからです。まず家族に何が起きているかという疫学、次に面会方針という唯一の強い推奨、そして家族支援介入の明暗を年代順に見たあと、特殊状況と当院の実装に落とします。

6-1. PICS-F — 心理だけでなく身体・社会経済まで

PICS-F（Post-Intensive Care Syndrome - Family）は2012年、「ICU患者家族に生じる臨床的に意義のある心理的障害（不安・抑うつ・PTSD・複雑性悲嘆）」として提唱されました。聖路加国際病院 救急科（白崎香純・一二三亨・大谷典生）を中心とするグループによる包括的レビューは、この定義を「打ちのめされた生活（devastated life）」として拡張し、**身体（疲労・睡眠障害）と社会経済（休職・離職・貯蓄喪失）まで含めるべきだ**と論じています [PICS-F AcuteMedSurg2024]。数値は強烈です——1か月時点で家族の44.9%が離職を余儀なくされ、1年時点で36.7%が貯蓄を失っていました。疲労はICU滞在中に約半数に影響し退室4か月後も持続、睡眠障害は4か月後も半数超で続きます [PICS-F AcuteMedSurg2024]。心理尺度だけを回すと、この領域の半分を見落とすことになります。

心理症状の縦断的経過は「数か月以内に短期的に改善し、その後（数か月～1年）はほとんど変わらないか、時に悪化する」という軌跡をたどります [PICS-F AcuteMedSurg2024]。したがって高リスク家族の早期予防・スクリーニングと、症状が持続する家族への長期的支援の両方が必要です。

実際の数字を見るとこの軌跡がよく分かります。原著のTable 3では、不安の有病率は1か月未満で42～62%、1～2か月で21～35%、6か月時点で15～40%と推移し、抑うつは1か月未満で16～53%から6か月で6～24%へ、PTSDは1か月未満のデータが乏しいものの3か月時点で10～69%、6か月で14～49%、12か月でも24%が報告されています [PICS-F AcuteMedSurg2024]。幅が広いのは研究間の異質性によるもので、単一の数字として一人歩きさせないよう注意してください。原著は「患者のICU入室時点で家族の精神状態を評価できれば、その後の変化を観察でき、長期フォローの中でPICS-Fを診断できる」と述べており、これが9章で扱う**入室時ベースライン測定**の必要性の根拠になっています。

表17 | PICS-Fのリスク因子と保護因子 — 変えられないものと介入可能なものを分ける

区分	全時期を通じて一貫した因子
患者側（変えにくい）	疾患重症度・せん妄・ICU在室日数・人工呼吸の長期化・死亡
家族側（変えにくい）	若年・女性・親であること
保護因子（介入可能）	医師・看護師とのコミュニケーションの不満足／情報提供の不足／説明の矛盾
環境（介入可能）	専用の家族面談室がない／待合室がない／1部屋2床以上

保護因子側で唯一独立して論じられているのが**レジリエンス**です。CD-RISC（Connor-Davidson Resilience Scale、25項目・自記式・5段階）で測定され、高得点ほど症状が抑制される傾向が報告されていますが、CD-RISCを用いてPICS-Fとの関係を明らかにした研究はまだ1件しかありません [PICS-F AcuteMedSurg2024]。宗教的信念も同様に保護的に働くとされますが、宗教・人種によって大きく異なるため、結果の解釈には注意が必要です。「説明の矛盾」自体が独立したリスク因子であることは見落とされがちです。「介護者から提供された情報に矛盾を感じた」「与えられた情報に矛盾があった」「情報を得るまでに時間がかかった」がいずれもリスク因子として挙がっており [PICS-F AcuteMedSurg2024]、**多職種が別々に別のことを言うこと自体が家族を傷つけます**。多職種カンファで「今日、家族に何をどう伝えたか」を1行で記録して共有する仕組みが、低コストで効く可能性があります。

6-2. 面会緩和 — 17ステートメント中で唯一の強い推奨

SCCMの成人ICU家族中心ケアガイドライン2024は、28名の多職種パネルが15のPICOをGRADEで検討し17のステートメントを出したものです [SCCM2024]。17項目のうち**強い推奨はただ1つ**——「緩和した家族の立ち入り方針をICUの既定の運用とする」ことです（確実性low）。根拠となった8件のRCTのうち最大のものがブラジルの36 ICUによるクラスター交差RCT、ICU Visits試験（1685例）で、患者のせん妄には差がありませんでした（18.9% vs 20.1%、P=0.44）が、家族の不安（中央値差-1.6、p<0.001）と抑うつ（差-1.2、p=0.003）が改善しました [ICU Visits JAMA2019]。効果は1年後も続き、PTSD症状は21% vs 30.5%、aPR 0.91（0.85-0.98）でした [ICU Visits ICM2024]。安全性への悪影響も検出されていません——ICU内感染3.7% vs 4.5%（P=0.38）、スタッフのバーンアウト22.0% vs 24.8%（P=0.36）。ただし介入は面会時間の延長単独ではなく、構造化ミーティングと情報冊子が付いていた点に注意してください [ICU Visits JAMA2019]。時間だけ伸ばして再現すると外れる可能性があります。

「面会でせん妄が減る」とは説明しない

効くのは家族の不安・抑うつ・PTSDであって、患者のせん妄ではありません [ICU Visits JAMA2019]。**面会は「家族の権利」ではなく「せん妄ケアの介入（ABCDEFのF）」**として位置づけ、正しい効能書きで説明してください。パンデミック期の制限を否定するものではなく、SCCMガイドライン自身も「面会が患者ケア・スタッフ業務量・バーンアウトに不釣り合いな悪影響を与えるなら制限は正当化されうる」と明記しています [SCCM2024]。

6-3. SCCM2024ガイドライン — 17ステートメントの全体像

強い推奨が1つしかないことは、この領域のエビデンスの薄さを正直に反映しています。確実性がmoderateに届いたのは家族向け教育プログラムの1件のみで、highは1件もありません [SCCM2024]。SCCMはこれまでに家族支援のガイドラインを2007年・2017

年と2度出しており、今回が3代目です。2017年版の後、ICUの家族支援・家族関与の取り組みには前例のない勢いが生まれましたが、そこへCOVID-19パンデミックが到来し、家族の立ち入りとスタッフのバーンアウトに深刻な悪影響を及ぼしました。2024年版は**パンデミック後の時代における再検討**という位置づけで、成人ICUに限定して15のPICOを扱っています。

表18 | SCCM2024の17ステートメント（要約） — **ほとんどが「やる方向は支持するが方法は決められない」**

領域	ステートメント	強さ／確実性
家族の関与	緩和した面会方針を既定とする	強い／low
	回診への家族同席の選択肢	条件付き／very low
	ベッドサイドケアへの参加	条件付き／very low
	蘇生の場合への立ち会い（支援スタッフ付き）	条件付き／low
家族のニーズ支援	家族向け教育プログラム	条件付き／ moderate
	臨床チーム向けツール	賛否なし／low
	ICUダイアリー	条件付き／low
	家族向け意思決定支援ツール	賛否なし／low
	死別後支援	条件付き／low
	精神的健康・心理的ニーズの支援	条件付き／low
	スピリチュアルなニーズの支援	条件付き／low
物理環境・公平性	家族支援ゾーン・支援的設備	Best practice statement
	公平なケアへの障壁の削減	Best practice statement
コミュニケーション支援	学際的家族カンファの標準化・VALUE	条件付き／low
	臨床家へのコミュニケーション訓練	条件付き／low
	研修者への高忠実度シミュレーション	条件付き／low
臨床家の支援	家族中心ケアを支える構造化プログラム	条件付き／low

実装の優先順位を考えるうえで大事なのは、**推奨も非推奨もされなかった2項目**です——臨床チーム向けの家族中心ケア支援ツールと、家族向けの意思決定支援ツール（decision aids）。後者は2017年版が「可能なら導入」と提案していた項目からの明確な後退です [SCCM2024]。家族向けの意思決定支援ツールについては、7件のRCTが検討されていますが、416名の代理決定者を対象にしたweb ベースdecision aidのRCTでは副次アウトカムのdecisional conflict（意思決定の葛藤）に群間差が出た一方、メタ解析全体では不安・抑うつ・PTSD・在室日数・死亡率のいずれにも差が見られませんでした [SCCM2024]。終末期の意思決定を行う90名の家族を対象にした別の仏RCTは情報パンフレットで3か月時点のPTSD・抑うつ割合が下がったと報告していますが、全体としては望ましい効果・望ましくない効果ともに些少と判断されています。**当院が新規にツールを買う・作る優先度は低く**、同じ資源を面会方針・家族カンファ・訓練に回すほうがガイドラインの支持は厚いということになります。家族カンファの型は**VALUE**ニーモニック（Value family statements・Acknowledge emotions・Listen・Understand the patient as a person・Elicit questions）で

標準化でき、初回家族面談は入室72時間以内が目安として引用されています [SCCM2024]。SCCMは執筆パネルとTHRIVE Patient and Family Support Committeeの有志により、2017年版のギャップ分析ツールキットと家族中心ケア資源一覧を改訂した新しいツールセットを公式サイトで公開しています。当院で家族中心ケアを見直す際は、独自にゼロから作るのではなく、まずこの既存ツールセットを参照し、当院の実情に合わせて取捨選択するほうが効率的です。

⚠ コミュニケーション訓練は「効く」と売り込まない

研修者への高忠実度シミュレーション訓練は条件付き推奨（確実性low）ですが、根拠となった最大のRCT（内科研修医・NP 472名）は臨床アウトカムをほぼ改善せず、**患者の抑うつ症状がわずかに増えました** [SCCM2024]。訓練プログラムを導入する際は「コミュニケーションの質は上がるが、患者転帰は変わらないかもしれない」と正直に説明したほうが、現場の納得が得られます。

ガイドラインの策定方法にも触れておきます。28名の多職種パネルが15のPICOに対し、2021年6月までの系統的検索（2023年3月まで更新）を医学図書館員が行い、抄録・全文とも2名の重複スクリーニングとCochrane Risk of Bias toolによるバイアス評価を経て、GRADEに基づき推奨を作成しました [SCCM2024]。投票はPanelVoiceを用い、適格投票者の70%以上が投票し80%超の同意でコンセンサスとする方式です。この手続きの厳密さは、逆に「厳密にやってもほとんどがlow～very lowの確実性にしかない」というこの領域の現実を裏づけています。

6-4. 家族支援介入の明暗 — なぜ効いたり効かなかったりするの

専従スタッフを置く介入は、担い手を変えながら3世代にわたって試されてきました。年代順に見ると、効果が消えていく過程が見えます。

表19 | 家族支援介入の変遷 — 担い手を変えても心理アウトカムは動かない

試験	担い手	デザイン	心理アウトカム	動いたもの
PARTNER	チーム全体	段階的ウェッジRCT	HADS 11.7 vs 12.0（差なし）	コミュニケーションの質・ICU在室日数短縮
看護師ファシリテーター単独	訓練された看護師	質的研究（RCT付随）	意思決定への影響なしと臨床医が明言	家族には有益と認識された
FICUS	指名の家族ナース	クラスターRCT・16 ICU	8アウトカム全て差なし	両群とも自然経過で改善
Caregiver Pathway	訓練済みICU看護師11名	単施設RCT・196人	6か月IES-R差 -6.8 (p=0.009)	患者生存家族でのみ効果、死別家族では悪化

PARTNER試験は米国の段階的ウェッジデザイン（同じICU群が時期によって対照期と介入期の両方を経験する設計）で、多職種チーム全体が家族支援を行い、家族の心理症状（HADS）は動かさなかったものの、コミュニケーションの質（QOC 69.1 vs 62.7、P=0.001）とICU在室日数（6.7 vs 7.4日、IRR 0.90、P=0.045）を動かしました [PARTNER NEJM2018]。段階的ウェッジは、全ICUがいずれ介入を受けられるという倫理的な利点がある一方、時期による効果（季節・スタッフの習熟）と介入効果を分離しにくいという弱点も持ちます。次に試された看護師ファシリテーター単独では、家族には有益と見なされたものの、役割の曖昧さと職種間

の縄張りの競合、ファシリテーター自身の心理的負担により実装が阻まれ、臨床医は「意思決定への関与を増やさず、意思決定そのものにも影響しなかった」と明確に否定しました [ICM2024]。

この2つを踏まえて設計された最新・最大の試験がFICUS（スイス16 ICU・885家族、1年追跡）です。専門訓練を受けた家族ナースが入室から退室後まで構造化ケア経路を提供したにもかかわらず、家族機能・レジリエンス・生活満足度・QOL・苦痛・不安・抑うつ・PTSDの**8アウトカムすべてで有意差なし**でした [FICUS ICM2026]。精神症状は両群とも時間とともに系統的に改善しており（苦痛6か月-27.8点など、いずれも $p<0.0001$ ）、観察される回復の多くは介入ではなく自然経過である可能性が高いという結果です。規定タイミングを5回以上満たしたのはわずか23.1%（95例）——**陰性の主因は「効かない」ではなく「届かない」**可能性が高いことも著者は認めています。加えて群間の背景に偏りがあり、介入群のほうが人工呼吸（60.3% vs 49.5%）とICU死亡（19.9% vs 13.2%）が多く、予定外入室は少ない（77.1% vs 89.9%）という違いがありました [FICUS ICM2026]。より重症な患者群に介入が割り付けられていた可能性があり、結果の解釈にはこの点も考慮が必要です。

一方、単施設・非盲検の Caregiver Pathway試験（ノルウェー、196人）は、①入室数日以内のニーズ評価と看護師面談、②退室時の支援カード、③一般病棟転出後の電話、④退院後3か月以内の振り返り面談という4接点で、訓練済みICU看護師11名が家族1人あたり平均75分をかけました [Caregiver Pathway ICM2025]。結果は6か月IES-Rが介入群25.8対対照群30.9（群間差-6.8、 $p=0.009$ ）と改善し、患者が生存した家族に限れば6・12か月とも約10点差（ $p=0.001$ ）に達しました。

遺族には別建ての支援を

Caregiver Pathwayでは**死別した家族で12か月時点で介入群が悪化**していました（IES-R群間差+11.3、 $p=0.013$ ）。侵入症状・過覚醒・抑うつも同方向でした [Caregiver Pathway ICM2025]。「良かれと思って」で遺族に同じ接触を繰り返さないでください。この結果はPICS-Fレビューが指摘する「お悔やみの手紙単独はむしろ抑うつとPTSDを増やす可能性がある」という知見とも符合します [PICS-F AcuteMedSurg2024]。

食い違う理由は3つ考えられます。①FICUSの忠実度23.1%が示すように、陰性の主因は「効かない」ではなく「届かない」可能性が高いこと。②単施設で開発者が回すと効き、多施設に移すと消えること。③担い手を変えても解決しない——PARTNER（チーム全体）→看護師ファシリテーター単独→FICUS（指名看護師）と3通り試して心理アウトカムは動きませんでした。**当院で導入するなら「誰がどれだけの熱量で回すか」が効果の大半を決めると見積もってください。**

6-5. 死別後支援の型 — 手紙単独ではなく段階的に

お悔やみの手紙（患者の死後15日目に医師と看護師が送る手書きの手紙）は、家族の抑うつとPTSD症状を増加させる可能性がある」と報告されています [PICS-F AcuteMedSurg2024]。ただし手紙を受け取った時点の遺族の心理状態が評価されていないため、手紙が直接影響したとまでは言えません。より安全とされるのは**3ステップ支援戦略**です——①差し迫った死に向けて遺族に心の準備をしてもらう家族会議、②積極的支援を提供する病室訪問、③患者の死後にお悔やみと区切り（closure）を伝える面談、という段階的なプロセスで、遷延性悲嘆症状を減らすのに有用でありうるとされています [PICS-F AcuteMedSurg2024]。SCCM2024ガイドラインも死別後支援を条件付きで推奨していますが、特定の介入を正式に推奨するに足るデータはないとしています [SCCM2024]。8件のRCTに基づく評価では、家族のケア満足度・意思決定への満足度・全般的な家族満足度のいずれも統計学的に有意な改善を示せなかった一方、明確な害のエビデンスもありませんでした。唯一意味のある差が見えたのは6か月時点の家族の不安で、介入群のほうが低

い傾向がありました。死別後支援は「現地の事情に合わせて調整すべき」というのがガイドラインの立場で、当院に画一的な手順を輸入するのではなく、資源とスタッフ負担を踏まえて設計する必要があります。

6-6. スピリチュアルなニーズ — 話題に出す人が少ない

SCCM2024ガイドラインは、家族のスピリチュアルなニーズの同定と支援を条件付きで推奨しています（確実性low）[SCCM2024]。根拠となった近年のRCT（Torke 2023）は、192組の重症患者と代理決定者のペアに**プロトコル化された能動的チャプレン支援**を提供し、代理決定者の精神的健康症状の改善とdecisional conflict（意思決定の葛藤）の減少を示しました。背景として、代理決定者の70%超が宗教またはスピリチュアリティを人生においてかなり重要・非常に重要と回答するというエビデンスがある一方、この話題が臨床医から持ち出されたり家族面談に組み込まれたりすることはまれです。当院でチャプレンサービスがある場合、面談の選択肢として能動的に知らせることが、この推奨に沿う最小の一手になります。

6-7. 臓器提供に立ち会う家族 — 経路で苦悩の質が違う

28研究の質的系統的レビューは、臓器提供に立ち会う家族の体験を「死を構成する」「争われる身体」「関係的な意味づけ」の3テーマに統合しています [CritCare2026]。脳死後提供（DBD）の家族は、人工呼吸で温かく保たれた身体という感覚的証拠が医学的宣告を上書きしてしまう認知作業に苦しみ、心停止後提供（DCD）の家族は、治療中止と提供の同意という2つの決定が近接して押し寄せ、臓器生着のための時間枠が別れの時間を切り詰めるという、**質の異なる困難**を負っていました。「争われる身体」テーマの下位テーマである**官僚的モノ化（bureaucratic objectification）**——死亡告知と提供依頼を切り離さない手順、臓器を一つずつ確認する同意書、書類の山——は、家族を傷つけているのが臨床医の不親切さではなく制度の側の設計であることを示しています [CritCare2026]。同レビューは欧米に偏り（欧州14・北米8研究）、日本ではcontrolled DCDが事実上行われていないという限界があります。

表20 | 臓器提供家族の体験・3テーマ — DBDとDCDで下位テーマが分かれる

テーマ	下位テーマ（抜粋）
死を構成する	宙ぶりの時間／身体的証拠の目撃／死の判定という争われる境界／橋としてのコミュニケーション
争われる身体	神聖な身体対臓器提供／人格中心の身体性／ 官僚的モノ化
関係的な意味づけ	儀式と関係的な別れ／家族による集合的解釈／関係の身体の延長／手続きの制約

著者らの結論は「普遍的な推奨」ではなく「文脈に応じた実践上の考慮事項」です——コミュニケーションの質、人格中心のケア、制度の柔軟性の3点を挙げています [CritCare2026]。当院で終末期・臓器提供にかかわる場面では、死亡告知と提供依頼を同じ面談で急がないこと、書類手続きを段階的に説明することが、官僚的モノ化を避ける具体策になります。

6-8. 患者にとって家族は「対処資源」でもある

ここまでは家族を「支援される対象」として見てきましたが、視点を反転させる知見もあります。ICUせん妄への患者・家族の対処を扱った10本の質的研究のメタ統合（7か国）は、患者にとって最も一貫して効いていた対処資源が**家族**だったと報告しています——10本中半数超で情緒的な存在と関係的サポートが挙げられていました [CritCare2026]。家族側のコーピングは2方向に分かれ、患者に向けたもの（そばにいて手を握る・能動的な再見当識づけ）と、自分自身の苦痛を管理するもの（情報探索・回避・肯定的再評価）があります。ただしこのメタ統合は効果を一切検証しておらず、10本中9本でコーピングは偶発的所見にすぎません [CritCare2026]。

それでも、家族を「面会者」ではなく「患者の見当識と情動を支える対処主体（coping agent）」として設計に組み込む発想の転換には価値があります。

患者への介入が家族に波及した例もあります。韓国5施設のRCTの二次解析では、ICU入室48時間以内の早期離床は、患者・家族介護者を個人単位で見ると不安・抑うつを意味のある形で減らしませんでした。退室6か月時点で「二人同時の中等症以上の不安・抑うつ」が32.5%対54.8%（調整OR 0.34）と有意に少なかったのです [CritCare2026]。心理的回復が個人ではなく関係（ダイアド）の単位で起きている可能性を示す探索的な所見ですが、著者自身が「仮説生成的」と位置づけている点は割り引いて読んでください。

6-9. 特殊状況 — 配偶者・パートナーは層別して見る

家族といっても立場によって負担は様々ではありません。FICUS試験の背景データでは、**配偶者・パートナー**が生活満足度・QOLの低さ、不安・抑うつの高さのいずれでも他の続柄より不良でした（ $p \leq 0.015$ ） [FICUS ICM2026]。配偶者は代理意思決定者であることが多く、日常生活の変化（収入・家事・介護）を最も直接に引き受ける立場でもあります。家族支援の対象を「家族」とひとくくりにはせず、**配偶者・パートナーには追加の目配りが要る**と考えてください。PICS-Fのリスク因子表でも「独居」がリスク因子として繰り返し挙がっており、配偶者を亡くした後の独居高齢者はとくに注意が必要です [PICS-F AcuteMedSurg2024]。

6-10. 実装 — 費用ゼロの一手から始める

ここまでの知見を統合すると、当院で今すぐ始められる一手が見えてきます。

表21 | 家族ケアの実装早見 — 効果が確認された接点から着手する

場面	やること	避けること
面会方針	緩和を既定に。「せん妄ケアの一部」と説明する	「面会でせん妄が減る」と言う
初回家族面談	入室72時間以内、VALUEニーモニックで構造化	説明する医師によって内容がぶれる
家族が強い不安を訴える	「そばにいて手に触れ、落ち着いた声で話す」を助言	心理士への紹介だけで終える
死が近い・死別後	面談→病室訪問→死後面談の3ステップ	お悔やみの手紙を単独で送る
評価のタイミング	入室時ベースライン+3か月・6か月	ベースラインなしで「PICS-Fによる悪化」と判定する

費用ゼロの最小実装として提案できるのが「家族への3つのお願い」カードです——①そばにいて手に触れ、落ち着いた声で話す、②今日の日付・場所・今起きていることを繰り返し伝える、③家から見慣れた物を持ってくる。「訂正しない・否定しない・議論しない」ことを明記します（指示がないと家族は「違うよ、ここは病院だよ」と否定してしまいがちです）。ただしこのカードの効果自体は検証されていないため、主要指標はカードの配布率と面会時の実施率に置いてください [CritCare2026]。

6-11. 家族の状態をどう測るか — 評価尺度13種類

家族の心理・身体・社会経済状態を評価する尺度は研究間で大きくばらついており、「普遍的に受け入れられた単一のツールは存在しない」というのがPICS-Fレビューの明言です [PICS-F AcuteMedSurg2024]。当院で退室後訪問のデータを取るなら、少なくとも心理・睡眠・QOL・ケアの質の4領域から1つずつ選んで固定してください。

表22 | 家族の評価尺度（PICS-Fレビューより抜粋） — 領域ごとに1つを選んで固定する

領域	尺度	項目数	カットオフ
不安・抑うつ	HADS	14	≥8
抑うつ	PHQ-9	9	≥10
PTSD	IES-R	22	平均>1.6
PTSD（短縮版）	IES-6	6	平均>1.75
複雑性悲嘆	ICG	19	≥25～30
睡眠	PSQI	9	睡眠障害の判定に使用
QOL	SF-36	36	—（利用料が必要）
ケアの質	FS-ICU 24	24	—
介護負担	Zarit-12	12	13

評価のタイミングは3か月・6か月が最も多く使われていますが、SCCMがICU生存者本人のPICSスクリーニングを退院後2～4週以内に推奨しているのに対し、**PICS-Fの時期は不明**と原文が明記しています [PICS-F AcuteMedSurg2024]。評価が早すぎると家族の困難の全体像を捉えられず、遅すぎると対応の機会を逃します。当院が独自にデータを取るなら、国際比較のために3か月・6か月を軸にしつつ、**入室時のベースライン測定を必ず設計に入れてください**——入室時点の家族の精神状態を測っておかなければ、長期の心理症状が本当にPICS-Fによるものかを判定できません。

6-12. 家族支援ゾーンと公平性 — best practice statement の2項目

SCCM2024ガイドラインのbest practice statementは、直接比較する研究がほとんど無いが実施が明らかに合理的な事項に使われる特別な区分です [SCCM2024]。家族支援ゾーン（休息スペース・身支度の場・機微な話ができる個室・ベッドサイドで楽に座れる余地）の設置と、言語・文化・期待の差という障壁を系統的に同定し減らす仕組みの2つがこれに該当します。PICS-Fレビューが挙げるリスク因子「専用の家族面談室がない」「待合室がない」「1部屋2床以上」は、この2項目とそのまま対応しています [PICS-F AcuteMedSurg2024]。ICU改善アンケートの設問に「家族の待機環境」「通訳・言語支援」を1問ずつ足すだけで、この領域のPDCAの入口ができます。

§7 記憶・人格の可視化・せん妄ケアの人間化

ICUで意識を失っていた時間は、患者にとって「無かった時間」ではありません。この章では、その空白を埋めようとするICUダイアリーがなぜ家族には効かないのか、患者の人格をどう可視化するか、そしてせん妄ケアそのものを人間化するとはどういうことかを扱います。

7-1. ICUダイアリー — 家族には効かないが、無意味ではない

ICUダイアリーは1984年のデンマークで始まった取り組みで、記憶を失った患者の中断された人生の物語を再構築するために、スタッフと家族が入室中の出来事を書き残します [PICS-F AcuteMedSurg2024]。最も著名な仏RCT（35 ICU・657例）は、患者のPTSD症状を減らしませんでした（29.9% vs 34.3%、P=0.39） [ICUダイアリー JAMA2019]。家族への効果を検証したRCT 3件と

前後比較1件を統合したSR/MAでも、**家族のPTSD発生率に差はありませんでした** [PICS-F AcuteMedSurg2024]。原文は「したがってICUダイアリーは家族に対して有益な効果を持たないように思われる」と率直に結論しています。ただし留保も付いています——ダイアリーはわかりやすい言葉で書かれた情報を家族にいつでも読み返せる形で提供し、医療者と家族のコミュニケーション改善に役立つツールではありうる、というものです。SCCM2024ガイドラインもICUダイアリーの提供を条件付き推奨（確実性low）としており、パネルの全体メタ解析ではむしろ**患者PTSDとの有意な有益な関連**を認めています [SCCM2024]——単一の仏RCTと全体メタ解析で結論が食い違うことは覚えておいてください。

導入するなら位置づけを変える

ICUダイアリーを「PTSD予防」として売り込むと、最大の仏RCTの結果と矛盾します [ICUダイアリー JAMA2019]。導入するなら「PTSD予防」ではなく「**記憶の空白を埋めるコミュニケーションツール**」として位置づけてください。この位置づけの違いが、期待値のずれを防ぎます。

7-2. 妄想的記憶を減らす — 鎮静戦略との接点

4章で扱ったとおり、ICU退室後の妄想的記憶は38.5%に生じ、事実記憶しか持たない患者が最もPTSD症状が少ないという結果でした [ICM2025]。ICUダイアリーが埋めようとしているのは、まさにこの「記憶の穴」です。妄想的記憶群のせん妄合併は41%にとどまり、残りはせん妄と診断されていません——つまり、せん妄と診断されなかった患者にも妄想的記憶は生じており、記憶の評価はせん妄評価だけでは代替できないということです。

7-3. 人格の可視化 — Get to Know Me Board

患者の人格を可視化するホワイトボードの質的研究（Mayo Clinic、患者38名・家族60名が同意）は、家族の**85%**が「名前・ニックネーム」の記載を有用と回答したと報告しています [GTKMB JPatientExp2023]。当院のHelloボードの直接の対応物です。この研究はMayo Clinic RochesterのICUで前向き質的研究として行われ、患者46名に打診し38名が同意、家族66名に打診し60名が同意しています [GTKMB JPatientExp2023]。対象者の58%が侵襲的または非侵襲的人工呼吸を受けており、ICU在室日数中央値は14日と長期化した患者が中心でした。ボードに記載する内容は、名前・ニックネームだけでなく、仕事や役割、大切な人、趣味や習慣といった「その人らしさ」の情報です。解析はGraneheim & Lundmanの内容分析（質的部分）と記述統計（量的部分）を組み合わせしており、単なる満足度調査ではなく、患者・家族の語りから失敗モードまで具体的に拾い上げている点が実務への示唆を厚くしています。4本の独立した研究が同じ一点に収束しています——アンゴラの看護職の語り、せん妄ケアの人間化の10項目の筆頭、このGet to Know Me Board、そして患者・家族の語りの主題統合。いずれも「その人を名前と呼ぶこと」の重要性を指しています [HumanIC JAdvNurs2023]。

❗ 最大の失敗モードは「掛けてあるだけ」

Get to Know Me Boardの研究では、**患者の17%**が「医療者は誰も使わなかった」と回答しています

[GTKMB JPatientExp2023]。ボードを作ることが介入の本体ではなく、**回診でそこを見て話しかけることが介入の本体**です。Helloボード刷新のタイミングで、呼ばれたい名前欄を最上段に固定してください。

7-4. せん妄ケアの人間化 — 「患者と話しているのは誰か」

ARDSサバイバーの手記への応答として書かれたレターは、鋭い問いを立てています——せん妄の患者について臨床医はベッドサイドで頻繁に話しているが、**せん妄の患者と話しているのは誰か**、というものです [せん妄の人間化 ICM2024]。手記の主人公Richardは6週間のICU滞在のほとんどを昏睡とせん妄の中で過ごし、後になって銃撃や追跡、性的虐待といった生々しい夢を思い出しましたが、悪夢と幻覚の体験を説明してくれた一人の看護師——彼と「話した」人——だけを覚えていました。脳のネットワークが乱れていても患者の人格は存在し続け、患者は自分の体験を自分自身の文脈に置きます。著者らは、せん妄管理がこの10年で進歩した次の段階として「せん妄ケアの人間化」を提唱しています。

表23 | ベッドサイドでの「せん妄ケアの人間化」10項目 — 追加コストなしで変えられる

項目	内容
尊重と信頼	患者の名前と敬称を使う、安全を確保する
コミュニケーション技術	個別化された言語・非言語の技術、ミラーリング、安心づけ
共感	患者の視点と体験を考慮する
人格	体験と患者の物語を尋ね、聴く
受容	再オリエンテーションとリフレーミング
同伴	適切なら手を握る、症状と耐容性を評価する
自律	実行可能な選択肢を提示する（椅子かベッドか、など）
レジリエンス	個人の対処戦略を尋ねる（情報・家族・祈り・音楽）
安全	継続性のある臨床医、環境を説明する、視力・聴力の補助具
希望	家族を統合する、個人の対処を支える

この10項目のうち、「よくあるせん妄体験について患者に説明する」は、Richardが唯一覚えていた看護師の行為でした [せん妄の人間化 ICM2024]。当院の看護ケアに明示的に組み込む価値があります。具体的な声かけの例としては、「今、少し混乱しているように見えます。ここはICUで、あなたは治療を受けています。混乱した感覚や怖い夢を見ることは、この治療を受けている多くの人に起きることです」といった一言で十分です。原因を説明し、それが特殊なことではないと伝えるだけで、患者が体験を「自分だけがおかしい」という孤立した恐怖として抱え込むことを防げます。8ステップの実践フレームでは、この10項目に加えて**身体抑制を「望まれない安全上の事象」としてモニタする対象**に位置づけています——不動・疼痛・口渇・転倒・ライン自己抜去・恐ろしい体験と並列に扱うということです。この位置づけの転換は、次章の身体抑制の扱い方に直結します。

薬は最後 — 順序を間違えない

症状マネジメントの順序は「まず痛みと不快を取る→次に環境と対話→最後に鎮静薬」です。図4のとおり、非薬物的な対応を尽くしてから薬に進んでください。

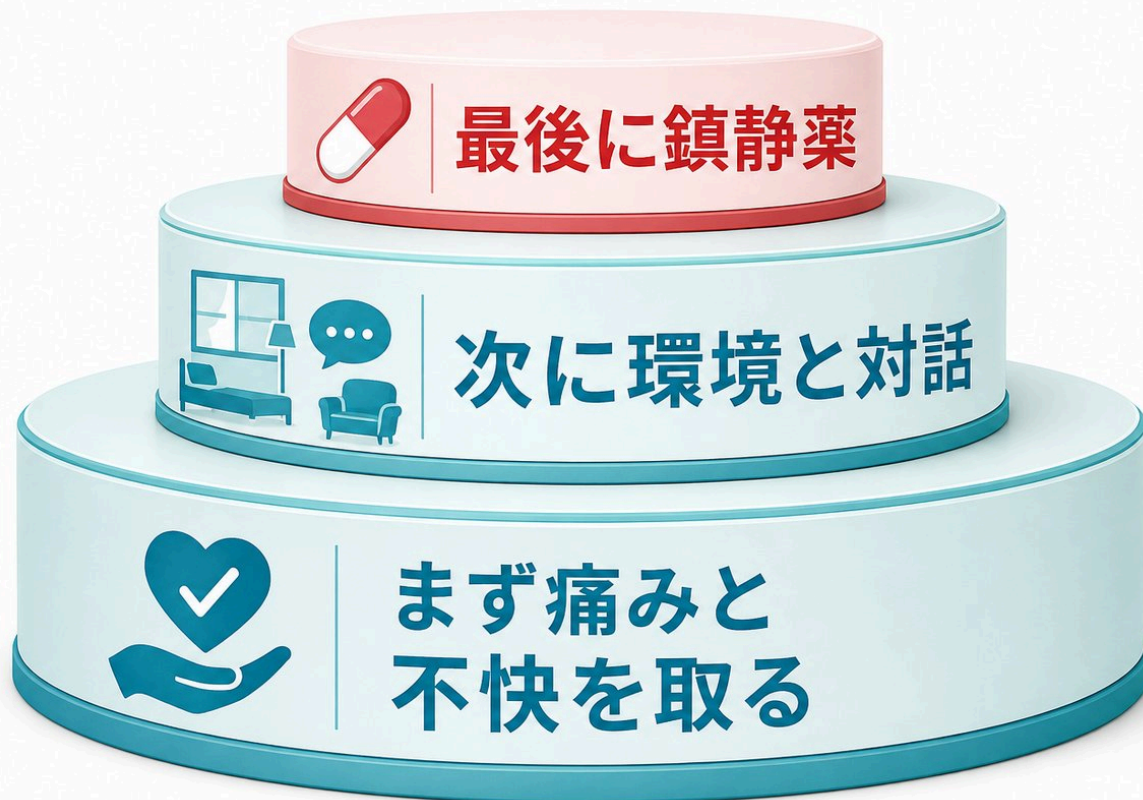


図4. 眠れない・落ち着かない患者への対応順序。

図の読み方 — 口渇・痛み・尿意といった不快の除去が第一段、次に環境（音・光）と対話、薬はいちばん上＝最後です。4章の睡眠覚醒調節薬のSR・MAはせん妄を約4割減らす一方、人工呼吸日数・死亡・在院日数は有意差なく、原著自身が「臨床実践の変更を支持しない」と述べています。順序を逆にしないでください。

7-5. 8ステップの実践フレーム

10項目を1回の回診で全部意識するのは現実的ではありません。原著が示す8ステップの実践フレームは、頻回の評価から始まり、症状マネジメント、望まれない安全上の事象のモニタリングまでを時系列で並べています [せん妄の人間化 ICM2024]。

表24 | せん妄ケアの人間化・8ステップ — 土台は人間化されたインフラ・面会・終末期ケア

ステップ	内容
1	意識・疼痛・せん妄・口渇・不安・疲労・不動の頻回で妥当な（再）評価
2	聴覚／視覚／移動の補助具でコミュニケーションを可能にし、名前を使い信頼を確立する
3	せん妄についてフィードバックし共感を示す。体験を尋ね、聴き、感情をミラーリングする
4	ガイドラインに従いせん妄の原因を同定し治療する
5	well-beingの機会を提供し、プライマリ・ナーシングと頻回な再評価でせん妄の負担を減らす
6	家族の統合・離床・口渇と排泄への対処・ICUダイアリー・照明と騒音を減らした睡眠改善
7	症状マネジメントは非薬物的介入を優先。改善しなければ特定の薬剤を使い、せん妄を悪化させる薬は減らす
8	身体抑制・不動・疼痛・口渇・転倒・自己抜去・恐ろしい体験という望まれない安全上の事象をモニタする

この8ステップを支える土台は、人間化された建築・インフラ／医療専門職へのケア／開かれたICU面会方針／終末期ケアの4つです [せん妄の人間化 ICM2024]。せん妄対策だけを単独で強化しても、面会が制限されたままでは土台が崩れます。1章のHU-CI 7領域との対応もここで再確認してください。

これは検証されたプロトコルではない

10項目・8ステップは、マドリードでのPICS会議での議論に基づく「最初のアプローチ（a first approach）」であり、転帰改善のエビデンスはまだありません [せん妄の人間化 ICM2024]。原著自体がLetter（書簡）であり研究データを含みません。当院で使うときは「検証済みの推奨」ではなく「実践のチェックリスト」として位置づけてください。

7-6. 実装 — 明日からの3つ

- 1. ラウンドで患者に「今日はどんな夢や体験がありましたか」と一言尋ねる。答えられなくても、尋ねる行為自体が「あなたと話している」というメッセージになります
- 2. Helloボードの呼ばれたい名前欄を確認し、回診で実際にその名前を使う。作っただけで満足しない
- 3. 身体抑制を検討する場面では、次章の監査項目（理由・部位数・総抑制時間・決定者・医師指示・家族通知）をその場でカルテに書く

§8 身体抑制とABCDEFバンドル

身体抑制は「安全のためにやむを得ない」という前提で語られがちですが、この章で見えるのは、抑制の頻度そのものより誰がどう決めているかという運用の弱さです。あわせて、この領域で唯一の大規模効果データであるABCDEFバンドルを確認します。

8-1. ANZICSの現状 — 抑制率ではなく運用を見る

豪州・ニュージーランド44 ICU・627例のポイントプリバレンス研究では、13人に1人（8%）が身体抑制を受けており、10年前とほぼ同じ割合でした [ANZICS ICM2020]。抑制患者の88%は人工呼吸中、85%は「患者自身への危険」が理由でしたが、その内訳を見ると、実際に危険な行動を示したのは5例のみで、大半（29例）は「危険がありうる」という予防的な抑制でした。

表25 | ANZICS身体抑制研究の主要数値 — 頻度より運用に注目する

項目	値
抑制率	8% (48/627例)
2か所以上の部位を抑制	73%
研究日の総抑制時間 (中央値)	13時間 (IQR 7–24)
決定者：ICU看護師	63%
署名済み医師指示なし	35%
近親者への通知あり	38% (不明40%)
抑制ガイドラインを持つ施設	82% (最終改訂から中央値15か月)

この研究で抑制による有害事象は収集されていません [ANZICS ICM2020]。「抑制は8%で行われており大きな害はなかった」とは読めないことに注意してください。28日時点の転帰は生存退院60%・一般病棟在院中27%・ICU在室中8%・死亡4%で、これも抑制の安全性を示すデータとしては使えません——抑制された理由（重症度が高い・神経系の診断が半数）が転帰に強く影響しているためです。著者らは、豪NZで抑制率が世界の他地域より低い理由として、**人工呼吸患者に対して通常1:1という看護配置**を挙げています——抑制を減らす議論は、教育やプロトコルだけでなく、夜勤帯の看護配置とセットで論じる必要があります。

⚠ 監査すべきは「決定プロセス」

抑制の有無だけを数えても改善にはつながりません。ANZICSが示した6項目——**理由／部位数／総抑制時間／決定者／医師指示の有無／家族への通知**——をそのまま監査項目として借りてください [ANZICS ICM2020]。決定者の63%が看護師単独、医師指示は52%のみという実態は、多職種による共同意思決定の仕組みが必要であることを示しています。

抑制の形態にも幅があります。研究対象の73%が2か所以上の部位を抑制されており、多くはミトンや抑制帯による手首の抑制でした [ANZICS ICM2020]。抑制帯の種類を変えることは代替策にはなりません——問われているのは「そもそも抑制が必要か」「必要ならいつ外せるか」という判断のプロセスであり、器具の選択はその後の話です。

8-2. ABCDEFバンドル — 唯一の大規模効果データ

ICU Liberation Collaborative（68 ICU・**15,226例**）は、A=痛みの評価と対応、B=覚醒・呼吸トライアル、C=鎮静薬の選択、D=せん妄の評価と対応、E=早期離床、F=家族の参加、この6要素の実施割合に比例して転帰が改善したと報告しました [Pun CCM2019]。

表26 | ABCDEFバンドルの効果量 — 実施割合が上がるほど転帰が改善

アウトカム	効果量 (95%CI)
7日以内の院内死亡	aHR 0.32 (0.17-0.62)
身体抑制の使用	aOR 0.37 (0.30-0.46)
せん妄	aOR 0.60 (0.49-0.72)
ICU再入室	aOR 0.54 (0.37-0.79)
有意な疼痛の報告	実施割合が上がるほど増加 (p=0.0001)

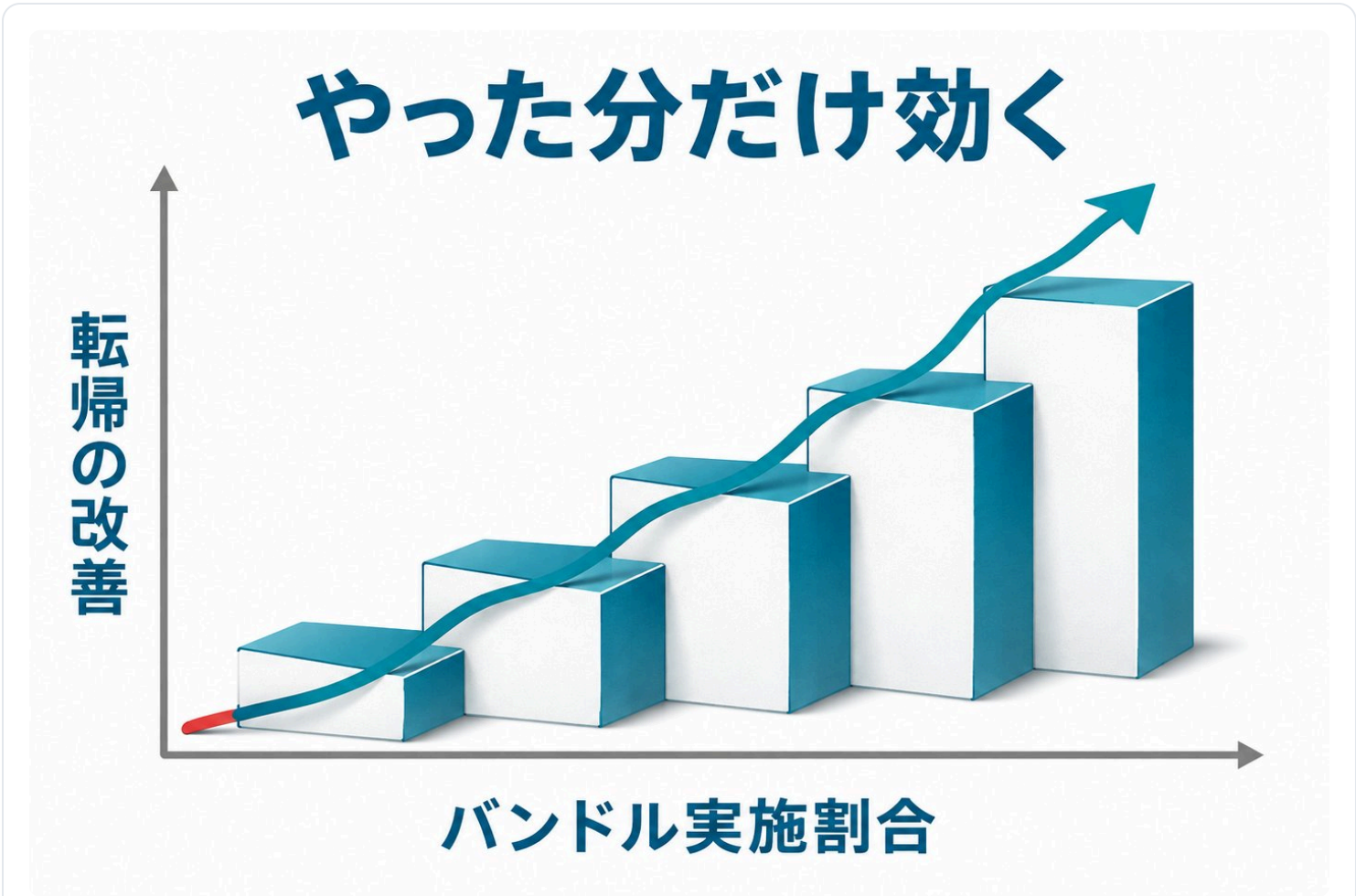


図5. ABCDEFバンドルの用量反応関係。

図の読み方 — 横軸はバンドル実施割合、縦軸は転帰の改善幅。「やるかやらないか」の二択ではなく、実施割合が上がるほど転帰が良くなる用量反応が上記すべての指標で見られます (all p<0.002)。階段の高さは関連であって因果の証明ではありません。

⚠ 2つの但し書き

①ランダム化試験ではなく、質改善コラボラティブに参加する意欲の高い68 ICUが母集団で、適応交絡を排除できません。「関連」であって「因果」ではないと伝えてください。②疼痛の報告だけが逆方向に増えています。浅い鎮静で患者が訴えられるようになった＝見えるようになった可能性が高く、指標導入初年度に数字が悪化することは事前に説明が必要です [Pun CCM2019]。

8-3. ABCDEFの中身 — 6要素をそれぞれ思い出す

表27 | ABCDEFバンドルの6要素 — 1つずつは既に習っている項目の集合

要素	内容
A	痛みの評価と対応 (Assess, prevent, manage pain)
B	覚醒トライアルと呼吸トライアル (Both spontaneous awakening and breathing trials)
C	鎮静・鎮痛薬の選択 (Choice of analgesia and sedation)
D	せん妄の評価・予防・管理 (Delirium: assess, prevent, manage)
E	早期離床 (Early mobility and exercise)
F	家族の参加とエンパワメント (Family engagement and empowerment)

この表を見ると、6章の面会緩和も7章のせん妄ケアの人間化も、実はABCDEFの一部（DとF）を詳しく展開したものだと分かります。バンドルという言葉に身構える必要はなく、すでに個別に習った項目を、同時に・記録しながら回すことがABCDEFの実体です。

8-4. 身体抑制と薬物的抑制は別問題

身体抑制を減らそうとして鎮静薬を増やすのは、多くの場合すり替えにすぎません。ANZICS研究の抑制患者のほとんどが人工呼吸中であったことは、鎮静と抑制がしばしば同時に使われている実態を示しています [ANZICS ICM2020]。4章で確認したとおり、薬は非薬物的な手段を尽くしたあとの最後の選択肢です。身体抑制を外すために鎮静を深くするのは、片方の問題をもう片方の問題に置き換えているだけで、解決にはなりません。抑制の是非を議論するときは、常に「今の鎮静深度は適切か」も同時に問い直してください。

8-5. 実装 — 抑制を検討する前にやること

抑制の代替として、せん妄の予防・早期発見、鎮痛優先の鎮静、早期離床、家族の面会時間拡大を先に置いてください。ABCDEFバンドルの「F」は家族参加で、6章で扱った面会緩和がそのまま抑制削減の一手になります。抑制は、これらを尽くしたあとの最終手段として位置づけます。

表28 | 抑制を検討する前のチェック — 可逆的原因を先に潰す

確認すること	次の一手
痛み・低酸素・尿閉・便秘はないか	原因治療を先に行う
せん妄の評価は済んでいるか	CAM-ICUで評価し、非薬物的介入を先行
家族は面会でできているか	面会緩和・付き添いの依頼
それでも危険が残るか	多職種で判断し、理由・部位数・時間・決定者・家族通知を記録

§9 退室後の連続ケアとPICS予防

ICUを出たあとの患者と家族に何をするかは、この領域でいちばん「良かれと思って」が裏目に出やすい部分です。この章では、手厚いフォローが害になった試験を先に置き、そのうえで「訪問を組織設計としてどう位置づけるか」というBEYOND PICSの枠組みを見ます。

9-1. 手厚いフォローは「治療」ではない — Suivi-Rea

フランス11病院のRCT（540例）は、ICU退室時・3か月・6か月に集中治療医・心理士・ソーシャルワーカーによる対面の多職種コンサルテーションを提供しましたが、12か月時点の不良転帰（死亡またはQOL重度障害）は、介入群のほうが有意に多いという結果でした（調整OR 1.49、95%CI 1.04–2.13） [Suivi-Rea ICM2024]。M12死亡は標準群32例に対し多職種群40例、一方で機能的・心理的・認知的スコアには群間差がありませんでした。著者ら自身、なぜ悪化したのかを説明できていません。

❗ 「フォロー外来を作れば良くなる」わけではない

この結果は、フォローアップの**形式**（対面・病院ベース・集中治療医主導・退室時+3か月+6か月）を検証せずに導入してはいけないという教訓です [Suivi-Rea ICM2024]。ICU専用VR動画が退院後のPTSD・不安・抑うつを改善しなかったこと（三群国際RCT、満足度8/10でも主要評価は完全陰性）も同じ方向のメッセージです。**「訪問すること」自体を成果にしない**でください。

この試験には注意すべき限界もあります。フランス11病院で2012～2018年という6年間にわたって登録されており、その間に標準ケアの内容自体が変化した可能性があります [Suivi-Rea ICM2024]。オープンラベルである一方、主要評価項目は盲検化された研究者が電話で収集しており、この点の質は保たれています。死亡単独の内訳（標準群32例・多職種群40例）は示されていますが、死亡単独のP値や、複合エンドポイントに占めるQOL障害と死亡それぞれの寄与は公表されていません。**機能・心理・認知スコアに群間差がないのに複合主要評価項目は悪化している**という内部の不整合は、著者自身も説明できていません。当院で同種のフォローアップを検討する際は、この不確実性を踏まえ、小さく始めて指標で確かめる姿勢を崩さないでください。

9-2. BEYOND PICS — 6本柱で「途切れている場所」を特定する

ESICM 4セッション合同の概念枠組みは、PICSとPICS-Fを別個の病態ではなく「同じ重症疾患体験がもたらした密接に関連した帰結」として扱い、退室前の予防から地域での長期生存者ケアまでを1本のパスウェイとして組み立て直します

表29 | BEYOND PICSの6本柱 — 臨床介入の指示ではなく組織設計の点検表

柱	意味	対応する動詞
Begin before discharge	退室前から始める	Prevent
Early follow-up and equitable access	早期フォローと公平なアクセス	Connect
Your journey	患者・家族の視点で回復を定義する	Personalise
Ongoing multidomain assessment	多領域の継続評価とリハビリ	Assess
Networked care	ネットワーク化されたケア	Coordinate
Driving improvement	改善を駆動する	Improve

この枠組みを当院に当てると、強いのはB（ABCDEF・早期離床・音／光の環境整備）とY（患者体験・ICU改善アンケート）、弱いのはE（退室後の最初の窓口が制度として無い）・N（病棟とかかりつけ医にICU情報が渡らない）・O（入室前のベースライン機能を記録していない）です。著者ら自身が「expert-informedであってconsensus-basedではなく、形式的な妥当性検証も受けていない」と明記しており [BEYOND PICS CritCare2026]、想定する読者は臨床医（回復志向の視点を持つため）・研究者（優先課題とギャップを見つけるため）・医療のリーダー（公平で患者中心の生存者サービスを設計するため）の3種類だとしています。この枠組みが引く退室後フォローの検証（コクランレビュー・Suivi-Rea RCT・遠隔多要素リハビリRCT）はいずれも否定的か相反しています。つまりこの枠組みは「フォロー外来を作れ」の根拠にはならず、**Suivi-Reaの教訓を覆すのではなく補強する側**にあります。

最初の一手は外来の新設ではない

BEYOND PICSが示す最初の一手は、新規の人員を要さない2つです——①退室時に患者・家族へ回復の見通しを説明する、②退室サマリーに「ICU滞在の要約＋PICSリスク」を定型で入れて病棟・地域連携室・かかりつけ医に渡す

[BEYOND PICS CritCare2026]。入室前のベースライン（ADL・認知・同居/就労）を退室後訪問の様式に3行足すだけでも、退室後に測った障害が新規のものか元からあったものかを区別できるようになります。

9-3. ネットワーク化されたケア — 情報を病棟・地域に渡す

BEYOND PICSの**N（Networked care）**は、ICUで得た情報が病棟・地域連携室・かかりつけ医にきちんと引き継がれているかを問う柱です [BEYOND PICS CritCare2026]。当院では現状、ICU滞在の詳細（せん妄の有無・人工呼吸日数・PICSリスク）が退院サマリーの中に埋もれ、転院先や外来担当医には十分に伝わっていない可能性があります。退室サマリーに「ICU滞在の要約＋PICSリスク」の定型欄を設けるだけで、この柱は動き始めます。追加の人員を必要とせず、既存の退院時サマリー作成のワークフローに1つの定型フォーマットを差し込むだけの改修です。地域のリハビリ施設・かかりつけ医との連携が薄いほど、患者が「ICUで何が起きたか分からないまま」外来を受診することになり、症状の解釈が遅れます。

9-4. 当院の退室後訪問 — 「治療」ではなく「回収」として設計する

Suivi-Reaの教訓（aOR 1.49＝悪化）を踏まえ、当院の設計原則は3つです——①長期フォロー外来を目指さない、②心理的転帰を主要目的にしない、③絞る（全例に薄い1回＋ハイリスクに追加1回）。

表30 | 退室後訪問の目的の切り分け — 患者のためとICUの学習のため

	目的A：患者のため	目的B：ICUの学習のため
狙い	移行期の不安を下げる／悪化の早期発見	ICUでの体験を回収し改善に戻す
聞くこと	体調・眠れているか・困っていること	ICUでつらかったこと・助かったこと
出口	病棟看護師・主科へ申し送り	ICU改善台帳に新規行として追加

試行期に見るのは「効果」ではなく「続くかどうか」＝実施率と所要時間です。2か月で効果は出ず、心理尺度を主要評価にすればほぼ確実に陰性で終わります。緊急再入室の半数は退室後5日以内に起きるとされ（JIPAD 69,594件）、2回目の訪問を退室3～5日目に置く根拠になっています。この全国規模のデータベースは、当院の再入室率をJIPAD全体の分布と比較できる数少ない外部比較の手段でもあり、退室後訪問の間接的な効果指標としても使えます。

9-5. 退室後訪問の実務チェックリスト

表31 | 退室後訪問の準備 — 開始前に決めておくこと

項目	決めておくこと
対象	全例に1回目（5分）。ハイリスクのみ2回目（10分、退室3～5日目）
担当	訪問時間・所要時間を記録し、実施率を追う
尺度	HADS・IES-Rなど推奨尺度から選び、入室時ベースラインを取る
出口	病棟看護師・主科への申し送り／ICU改善台帳への追加、の2経路を分ける
評価	2か月間は「効果」ではなく「実施率」だけを見る

9-6. 家族への訪問設計 — 個人ではなくダイアドで考える

6章で扱った早期離床の二次解析（韓国5施設RCT・156例の生存者と113名の主介護家族）は、患者・家族を個人単位で見ると心理症状に差がない一方、退室6か月時点で「二人同時の不安・抑うつ」が有意に少ないという所見を示しました（32.5% vs 54.8%、調整OR 0.34）[CritCare2026]。退室後訪問で患者だけ、あるいは家族だけを評価するのではなく、**同席するペアとして状態を確認する**という発想の転換が、この所見からは示唆されます。ただし著者自身が「探索的」「仮説生成的」と位置づけている点は割り引いてください。

9-7. PICS評価尺度の推奨 — 何を測るかを先に決める

日本集中治療医学会PICS委員会による754研究のスコアピングレビューと修正デルファイは、患者本人のPICS評価尺度を20種類に絞って推奨しています。対象領域は身体機能（ICU-AW・握力・6分間歩行など）、認知機能（MMSE・MoCAなど）、精神機能（不安・

抑うつ・PTSD)の3領域にまたがります。754研究のスコアリングレビューという大規模な母集団から、修正デルファイ法で専門家の合意を積み上げて20種類に絞り込んだ手続きであり、当院が独自に尺度を選ぶより、この推奨リストから選ぶほうが他施設との比較可能性を保てます。家族側(PICS-F)についてはHADS・IES-R・SF-36の3つが推奨されました。退室後訪問を始める前に、当院がどの尺度を使うかを先に決めておくと、後から他院・他研究と比較できるデータになります。

表32 | PICS評価尺度の推奨（日本集中治療医学会PICS委員会） — 患者と家族で使う尺度が違う

対象	領域	推奨尺度
患者本人	身体・認知・精神	20種類（領域別に推奨。詳細はガイドライン参照）
家族（PICS-F）	不安・抑うつ／PTSD／QOL	HADS／IES-R／SF-36

当院の退室後訪問で最低限そろえる3点

①患者・家族それぞれの入室時ベースライン、②3か月・6か月の固定評価時点、③HADS・IES-Rなど推奨尺度からの選択——この3点を最初に決めてから訪問を開始してください。あとから尺度を追加・変更すると、データの比較可能性が失われます。

§10 当院での実践 — Hotel ICUをどう動かしているか

ここまでの各論を、当院がどう組織として回しているかに接続します。Hotel ICUは思いつきの名前ではなく、1章で見たHU-CIの7領域と対応する、当院なりの人間化計画です。

10-1. Hotel ICUの6つの柱と2つのエンジン

当院のHotel ICUは6つの柱で構成されます。患者・家族向けが①ホスピタリティ（個別化ケア／騒音・光・温度の管理／柔軟な家族面会／わかりやすい意思決定支援）②Human Care（不安と恐怖に寄り添う／毎日の挨拶と処置前の声かけ）③世界最高の医療。医療者向けが④働きやすい環境⑤Wellbeing⑥プロフェッショナルとしての満足感です [当院 Hotel ICU]。発想の源流はVincentの「Fast Hug」という語呂合わせと、「2050年のICUは5つ星ホテルのようになる」という未来像です [Vincent ICM2017]。Fast Hugは、毎日の回診で見落としがちな基本的ケア項目（栄養・鎮痛・鎮静・血栓予防・頭位挙上・ストレス潰瘍予防・血糖・皮膚ケアなど）を「1日1回の抱擁」に見立てた語呂合わせで、Hotel ICUという発想はその延長線上に、患者の体験そのものを毎日確認する項目として位置づけられます。

エンジン1＝連続ケアはICU前・中・後で切れない患者ケアをつくること、エンジン2＝改善サイクルは現場の声を毎年集め必ず返し進捗を出すことです。どちらが欠けてもHotel ICUは掛け声で終わります。

「あなたの想いをつなぐシート」は、入室前あるいは入室直後に本人・家族から聴取する、呼ばれたい名前・大切にしていること・不安に思っていることなどを記録するシートです。運用3年で認知度は73%に達していますが、記載された内容が実際のケアラウンドやHelloボードに転記されず埋もれてしまうことが課題として残っています。

表33 | 連続ケア4施策 — 1人の患者の時間軸に並んだ1本の線

段階	施策	状態	解いている問題
ICU前	あなたの想いをつなぐシート	運用3年・認知度73%	その人が何者かを事前を知る
ICU中①	Helloボード	導入済	人格の可視化（7章）
ICU中②	ケアラウンド	実施中	症状と体験を定期的に取りに行く（2章）
ICU後	ICU退室後訪問	これから	移行期の不安・PICSの早期発見（9章）

ボトルネックは施策そのものではなく、**施策と施策の「あいだ」＝情報が次に渡らないこと**です。解は「患者体験カルテ（1枚）」で転記をゼロにすること——①この人は誰か②楽しみ・生きがい③今いちばん困っていること④本人・家族に伝えたこと⑤退室後に確認すること、の5欄が同じ1か所に積み上がる設計です [当院 Hotel ICU]。

10-2. 現場の声 — 2026年ICU改善アンケート

2026年のアンケートは総件数145件（課題106件・良い所29件・感謝10件）で、**最大のクラスターは「音」（10件）**でした [当院 ICU改善アンケート2026]。一方「良い所」の過半は「雰囲気明るい」「話しやすい」など、音の課題と**同じ性質**から生まれています。だから打ち手は量の抑制ではなく、**場所と時間の線引き**——場所はベッドサイド・処置中＝患者の場／ステーション＝業務の場、時間は夜間Quiet Time、測るのは5章で示した騒音計の定点設置です。個人を注意する運用にはしません（続かないため）。

10-3. 今年度の重点3つ

表34 | 今年度の重点施策 — 優先順位と費用

#	施策	なぜこれか	費用
1	音のプロジェクト（場所と時間の線引き＋dB測定）	アンケート最大クラスター	ほぼゼロ
2	睡眠バンドル（調光＋アイマスク・耳栓＋Quiet Time＋RCSQ）	照明予算が今年度つく。①と統合できる	予算済＋数万円
3	ICU退室後訪問の立ち上げ	連続ケアの最後の欠けたピース	人的コストのみ

退室後訪問は9章の原則（治療ではなく回収、心理的転帰を主要目的にしない、絞る）で試行します。試行期に見るのは「効果」ではなく「続くかどうか」です。

10-4. 指標ダッシュボード — 「良さ」を数字にする

Hotel ICUの最大の弱点は「良さが数字にならない」ことです。運営会議・経営戦略会議・病院に説明し続けるために、四半期更新の指標ダッシュボードを既存データから組み立てています。

表35 | 指標ダッシュボードの構想 — 既存データで取れるものから始める

領域	指標
患者体験	RCSQ（睡眠）／口渇スコア／TOURS Scale（挿管患者・週1）
環境	夜間騒音dB（定点1週間）／夜間平均照度
ケアのプロセス	ケアラウンド実施率／Helloボード記入率／つなぐシート記入率／退室後訪問実施率
転帰	せん妄割合／身体抑制率／緊急ICU再入室率（JIPADで全国比較可）
スタッフ	改善アンケート定量7問（年次比較）／離職率／時間外時間

ここまでの各章で扱った尺度（口渇NRS・J-RCSQ・TOURS・ANZICSの抑制監査項目・PICS-F評価尺度）は、すべてこのダッシュボードのどこかの領域に対応しています。個別の評価を積み上げると、そのまま組織のダッシュボードになる設計です。四半期ごとに運営会議・経営戦略会議へこの1枚を提示し続けることが、Hotel ICUを「掛け声」で終わらせないための最後の仕掛けになります。数字が動かない四半期があっても、測り続けること自体に価値があります——測っていないければ、そもそも動いたかどうかも分からないからです。

10-5. 研修医・若手が明日からできる3つ

- 1. 受け持ち患者に口渇NRSを2問聞く。5点以上なら看護師と時刻を決める。費用ゼロ、許可も不要
- 2. Helloボードを回診で「見て、話しかける」。7章のとおり、患者の17%が「医療者は誰も使わなかった」と回答しました。ボードを作るのではなく、見て話しかけることが介入の本体です
- 3. 身体抑制を指示するときに理由・開始時刻・決定者をカルテに書く。ANZICSでは決定者の63%が看護師で、医師指示は52%、家族通知は38%でした（8章）

§11 ピットフォールと特殊状況

この章は「よくやる誤り」と「一般化できない集団」の2本立てです。エビデンスの読み違いは、良い意図をそのまま害に変えます。ここまでの各章で個別に触れた注意点を、ラウンド前の最終チェックとして使える形にまとめ直します。

11-1. よくある誤り9つ

① 口の湿り具合で口渇を判定する

視診は速く「湿っている」は安心できる所見に見えますが、口渇NRSと口腔水分は $\rho=-0.01$ = 無相関です。ラウンドの定型設問に入れ、視診より先に聞いてください。

② 満足度を有効性の証拠にする

ICU専用VRは満足度8/10・有害事象ゼロで、6か月のIES-Rは $\beta=0.32$ ($p=0.87$) = 完全陰性でした。FICUSも満足度は上がったのに8アウトカム全て陰性です。カンファでこの2つを混ぜないでください。

③ J-RCSQ を挿管・鎮静患者に使う

検証されたのは非挿管・非鎮静・ICDSC $\leq$ 2の患者の総得点だけです。「昨夜は深く眠れたようです」を項目スコアで主張しないでください。

④ 「面会でせん妄が減る」と説明する

ICU Visitsでせん妄は18.9% vs 20.1% (P=0.44) と減っていません。効くのは家族の不安・抑うつ・PTSDです。正しい効能書きで通せば、後で梯子を外されません。

🚩 ⑤ 予後改善を約束する

この領域で言えるのは症状スコア・家族の心理・実施率までです。ABCDEFのaHR 0.32ですら非ランダム化の「関連」。環境改善で約束できるのは**環境指標の改善**までです。

⑥ 「掛けてあるだけ」で満足する

Helloボードも口渴バンドルも家族カードも、主要指標を「実施率」に置いてください。FICUSの忠実度23.1%、対照群のリップ保湿0.5回——**陰性の正体は「効かない」ではなく「届かない」**ことが多いのです。

⑦ 「効かない」を「やらない」に短絡する

陰性試験が並ぶ領域では虚無に振れるのが楽ですが、教訓は「やめる」ではなく**「全員に手厚く、は正解ではない」**です。対象・目的・期間を絞り、指標で確かめてください。

⑧ SCCM2024の「推奨」と「強い推奨」を混同する

公平性の項目（#13）は原文が“recommend”と書いていますが、格付けはbest practice statementであって強い推奨ではありません。17項目中「強い（strong）」と格付けされたのは面会緩和の1項目だけです。BPSでは“recommend”、条件付き推奨では“suggest”というGRADEの語法が使われているだけで、強さの格付けとは別です [SCCM2024]。

⑨ 死別家族に生存家族と同じ接触を続ける

Caregiver Pathwayでは死別家族で12か月時点に介入群が悪化しました（+11.3点、p=0.013）。お悔やみの手紙単独もPTSD・抑うつを増やす可能性があります。「同じ手厚さ」を死別後にも続けるのは誤りです。

⑩ 環境測定を平均値だけで報告する

音も光も、平均値・中央値は問題を隠します。夜間の照度中央値0 luxでも20 lux超のイベントが1時間に7～16回起きています。報告するのは平均ではなくイベント回数と、途切れない静穏・暗闇の割合にしてください。

⑪ 単一の家族支援試験の結果を一般化する

PARTNER・看護師ファシリテーター・FICUS・Caregiver Pathwayは、担い手も規模もまったく違います。「家族支援は効かない」も「家族支援は効く」も、どの試験を指しているかを明示しないまま語らないでください。

⑫ 抑制の代替として鎮静を深くする

身体抑制を外すために鎮静だけを深くするのは、8章で見たとおり問題のすり替えです。鎮静を深くすればせん妄・妄想的記憶のリスクがむしろ上がる可能性があり、根本的な解決にはなりません。

11-2. 特殊状況（現時点で分かっている範囲で）

表36 | 特殊状況ごとの注意点 — 一般化できない集団

状況	注意点
挿管患者	口渇バンドルの根拠研究はほぼ非挿管。外挿の確証はなく、実施率と症状スコアで確かめながら進める
自己申告できない患者	ICU患者の最大1/2。SOTの目視は覚醒をPSGの約1/5しか拾わない。「測れなかった」と記録するのが誠実な対応
死別した家族（遺族）	Caregiver Pathwayでは12か月で介入群が悪化。お悔やみの手紙はPTSDを増やした研究がある。別建ての支援を用意する
配偶者・パートナー	FICUSで生活満足度・QOLが低く不安・抑うつが高い（ $p \leq 0.015$ ）。層別して見る
臓器提供に立ち会う家族	DBDとDCDで苦悩の質が異なる。DBDは体の温かさが死の宣告と矛盾し、DCDは時間枠が別れの時間を切り詰める
子どもの面会	10推奨（ICM2023）があるが当院に方針の記載がない。「衛生要件が満たされれば感染リスクを高めることはない」
感染症流行期の面会制限	面会緩和の推奨根拠は8RCTすべてCOVID-19前。SCCM2024も「不釣り合いな悪影響があれば制限は正当化されうる」と明記。制限を発動する条件と解除の道筋を事前に決めておく
日本のICUへの外挿	口渇の質的研究はデンマーク、TOURSはフランス、ICU Visitsはブラジル、SCCM2024の8RCTはすべてCOVID-19前。当院の配置・鎮静・面会の前提はどれとも違う

この表に共通するのは、「一般化できない」ことを理由に何もしないのではなく、当院で同じ指標を測りながら慎重に導入するという態度です。外部のエビデンスは出発点であって、当院の実測データが最終的な判断材料になります。

§12 症例の解決

72歳男性、抜管当日、飲水禁止、粘膜は湿って見える患者への答えは、まず**口渇NRSを2問聞くこと**です。粘膜の湿りは判断材料になりません ($p=-0.01$)。仮に強度8・苦痛7なら重度で、最も頻度が高く最も強い症状が放置されている状態です。嚥下評価前で飲水はできなくても、氷水スワブとメントールリップは別の話——絶飲食を「何もできない」と混同しないでください。効果は1時間で戻るため、「今あげる」ではなく時刻を決めて記録します。

受け持ち看護師の「氷片、あげていいですか」への最も良い答えは、イエスでもノーでもなく「まず2つ聞かせて」です。口渇強度・苦痛のNRSを確認したうえで、氷水スワブとメントールリップを時刻表に載せる相談をしてください。

奥さんの「一睡もできていない」「私も何もしてあげられなくて」という言葉には、2つの答え方があります。睡眠については、この患者は非挿管・非鎮静・せん妄なしでJ-RCSQが使える対象なので朝に総得点で確認し、今夜できるのは足し算より引き算（頭側1mのアラーム音量・輝度、深夜の会話）です。睡眠薬から入りません。「何もしてあげられない」には、面会時に家族が口腔ケアを手伝える運用を提案してください——口渇バンドルへの家族の参加は、家族の無力感を減らす低コストな一手です。

退室に向けては、PICSリスク因子（せん妄なし・人工呼吸5日・敗血症性ショック）を踏まえ、退室サマリーに要約とPICSリスクを記載し、退室翌日の訪問で「ICUでつらかったこと」を患者に、「眠れているか・仕事は続けられそうか」を家族に聞きます。可能であれば、この時点で家族の不安・抑うつを簡易に確認し、入室時点との比較ができるよう記録に残してください——入室時のベースラインがなければ、後で変化を評価できません。

測らない苦痛は、存在しないことになる。これがこの領域全体を貫く1文です。口渇も、不安も、家族の負担も、まず聞かなければ「無かったこと」として記録が進んでしまいます。研修医としてできる最初の一步は、難しい介入を覚えることではなく、**聞く順番を毎回揃える習慣**をつけることです。この症例のように、迷ったときほど早見表の1行目に戻ってください——口渇NRSの2問から始めるといふ、いちばん単純な一步が、いちばん見落とされている一步でもあります。

主要文献

- Wilson ME, Beesley S, Grow A, et al. Humanizing the intensive care unit. Crit Care. 2019.
- Nin Vaeza N, Martin Delgado MC, Heras La Calle G. Humanizing intensive care: toward a human-centered care ICU model. Crit Care Med. 2020.
- Saltnes-Lillegård C, et al. Self-reported symptoms experienced by ICU patients: prospective observational multicenter study. Intensive Care Med. 2023.
- Ambrosino N, et al. Dyspnoea in mechanically ventilated critically ill patients: an ERS/ESICM statement. Intensive Care Med. 2024.
- VonStein M, Buchko BL, Millen C, Lampo D, Bell T, Woods AB. Effect of a scheduled nurse intervention on thirst and dry mouth in intensive care patients. Am J Crit Care. 2019.
- Beltrán Salazar OA. Impersonal care or humanized care: a decision made by nurses? Hourglass model. Invest Educ Enferm. 2016.
- Sili EM, et al. Humanized care in the ICU: discourse of Angolan nursing professionals. Rev Bras Enferm. 2023.
- Vincent JL. Give your patient a fast hug (at least) once a day, and think of ICU as a hotel. Intensive Care Med. 2017.

- Halm MA. Managing thirst in the critically ill. *Am J Crit Care*. 2022;31(2):161-165. doi:10.4037/ajcc2022475
- Doi S, Nakanishi N, Kawahara Y, Nakayama S. Impact of oral care on thirst perception and dry mouth assessments in intensive care patients. *Intensive Crit Care Nurs*. 2021.
- Zhang L, et al. Effect of a scheduled oral care bundle on thirst in non-ventilated ICU patients: RCT. *Aust Crit Care*. 2021.
- Lemyze M, et al. Effect of mini ice cubes on thirst intensity in critically ill patients. *J Pain Symptom Manage*. 2020.
- Kalfon P, et al. Comfort programme reduces thirst and other discomforts in the ICU: pragmatic cluster RCT. *Intensive Care Med*. 2017.
- Puntillo K, et al. A randomized trial of oral care interventions for thirst in critically ill patients. *Intensive Care Med*. 2014.
- Richards KC, Wang Y-y, Jun J, Ye L. A systematic review of sleep measurement in critically ill patients. *Front Neurol*. 2020.
- Murata H, Oyama Y, Fuse K, et al. Reliability and validity of the Japanese version of the Richards-Campbell Sleep Questionnaire (J-RCSQ). *Nurs Open*. 2019.
- Bodet-Contentin L, et al. Development and validation of the TOURS scale to assess well-being and sense of security of intubated ICU patients. *Crit Care*. 2026.
- Lewis K, Balas MC, Stollings JL, et al. Focused update to the PADIS guidelines. *Crit Care Med*. 2025.
- Circadian rhythm medicine in the ICU: environment, adjunct therapies, and organ support — What's New. *Intensive Care Med*. 2023.
- Ramelteon, suvorexant, and lemborexant for delirium reduction in hospitalized adults: systematic review and meta-analysis (24 studies, 4489 patients). *Crit Care Med*. 2025.
- Delusional memories and PTSD symptoms up to 1 year after ICU discharge: multicenter longitudinal cohort (n=426). *Intensive Care Med*. 2025.
- ICU noise has not changed in decades: a narrative review of sources, effects, and interventions. *Crit Care Res Pract*. 2026.
- Darbyshire JL, Müller-Trapet M, Cheer J, Fazi FM, Young JD. Mapping sources of noise in an intensive care unit. *Anaesthesia*. 2019.
- Light in the ICU is about darkness fragmentation, not brightness: observational cohort (222 patients, 14.6 million measurements). *Crit Care*. 2026.
- Designing the ICU of the future: patient-centred bedspace design to optimize recovery. *Crit Care*. 2023.
- Lau YH, et al. Post-intensive care syndrome: a state-of-the-art review. *Singapore Med J*. 2026.
- Shirasaki K, Hifumi T, Nakanishi N, Nosaka N, Miyamoto K, Komachi MH, Haruna J, Inoue S, Otani N. Postintensive care syndrome family: a comprehensive review. *Acute Med Surg*. 2024;11(1):e939. doi:10.1002/ams2.939
- Hwang DY, Oczkowski SJW, Lewis K, et al. Society of Critical Care Medicine Guidelines on Family-Centered Care for Adult ICUs: 2024. *Crit Care Med*. 2025;53(2):e465–e482.
- Rosa RG, et al. Effect of flexible family visitation on delirium among patients in the ICU: ICU Visits randomized clinical trial. *JAMA*. 2019.
- de Souza JMB, et al. Flexible family visitation and 12-month PTSD symptoms in family members (ICU Visits). *Intensive Care Med*. 2024.

- White DB, Angus DC, Shields AM, et al. A randomized trial of a family-support intervention in intensive care units (PARTNER). *N Engl J Med*. 2018.
- Nurse facilitator interventions for ICU family communication: why they fell short — qualitative study nested in a multicenter RCT. *Intensive Care Med*. 2024.
- Family systems care intervention for ICU family caregivers: cluster RCT (FICUS), 16 ICUs, 885 families. *Intensive Care Med*. 2026.
- The Caregiver Pathway: a four-step intervention for ICU family caregivers, randomized controlled trial. *Intensive Care Med*. 2025.
- Family experiences witnessing organ donation: qualitative systematic review of donation after brain death and circulatory death (28 studies). *Crit Care*. 2026.
- How patients and families cope with ICU delirium: meta-aggregation of qualitative studies (MMSR, 10 studies). *Crit Care*. 2026.
- Early mobilization and dyadic psychological distress in ICU survivor-caregiver pairs: secondary analysis of a randomized trial. *Crit Care*. 2026.
- Sharshar T, Grimaldi-Bensouda L, Siami S, et al. A randomized clinical trial to evaluate the effect of post-intensive care multidisciplinary consultations on mortality and quality of life at 1 year (Suivi-Rea). *Intensive Care Med*. 2024.
- BEYOND PICS: a conceptual framework for post-ICU recovery across six pillars, ESICM four-section collaboration. *Crit Care*. 2026.
- Garrouste-Orgeas M, Coquet I, Périer A, et al. Effect of an ICU diary on posttraumatic stress disorder symptoms among patients receiving mechanical ventilation: a randomized clinical trial. *JAMA*. 2019.
- Nydahl P, Ely EW, Heras-La Calle G. Humanizing delirium care. *Intensive Care Med*. 2024.
- Get to Know Me Board: making patients' personhood visible in the ICU — qualitative study. *J Patient Exp*. 2023.
- What humanizes and what strips humanity from the ICU: thematic synthesis of patient and family narratives (HumanIC, 15 studies, 10 countries). *J Adv Nurs*. 2023.
- Maiden MJ, Bone A, Fitzpatrick M, on behalf of The George Institute for Global Health and the ANZICS Clinical Trials Group. Physical restraint of patients in Australia and New Zealand intensive care units. *Intensive Care Med*. 2020.
- Pun BT, Balas MC, Barnes-Daly MA, et al. Caring for critically ill patients with the ABCDEF bundle: results of the ICU Liberation Collaborative in over 15,000 adults. *Crit Care Med*. 2019.